

Estabilidad en EPOC:

Un objetivo clínico alcanzable con
estrategias terapéuticas integradas

Javier Enrique Fajardo-Rivero

Internista y Neumólogo
CRI HMB, HRSG



Conflictos de Interés

Pagos por conferencias, asistencia a congresos y consultoría	Zambon, Novartis, Boehringer Ingelheim, GSK, Bayer, Glenmark, AZ, Sanofi, Novonordisk y Grupo Amarey, Carnot Laboratorios
Acciones o relaciones familiares con la industria farmacéutica	No
Relación con la industria del tabaco	No
Participación en guías de practica clínica	No
Ocupación e investigación	Cuidados Respiratorios Integrales Hospital Manuela Beltrán E.S.E (Socorro /Sder) Hospital Regional de San Gil E.S.E (S. Gil / Sder)
Otros	Los puntos presentados en la charla derivan de la revisión de los datos actuales y las opiniones reflejan mi punto de vista

Información de seguridad Trelegy Eliipta:¹

Contraindicaciones

Trelegy Eliipta está contraindicado en pacientes con alergia severa a las proteínas de la leche o que han demostrado hipersensibilidad al furoato de fluticasona (FF), umeclidinio (UMEC), vilanterol (VI) o cualquiera de los excipientes.

Advertencias y Precauciones

Usar con precaución en pacientes con hipertiroidismo, diabetes o epilepsia.

El uso de Trelegy Eliipta no se ha estudiado en pacientes con asma y no se recomienda en esta población de pacientes. Trelegy Eliipta está destinado para el tratamiento de mantenimiento de EPOC.

No debe utilizarse para aliviar síntomas agudos, es decir, como terapia de rescate para el tratamiento de episodios agudos de broncoespasmo. Los síntomas agudos deben tratarse con un broncodilatador inhalado de acción corta.

Los pacientes no deben suspender la terapia con Trelegy Eliipta sin la supervisión de un médico ya que los síntomas pueden recurrir después de la interrupción.

Reacciones Adversas

Comunes ($\geq 1/100$ a $< 1/10$): Neumonía, infección de vías respiratorias superiores, bronquitis, faringitis, rinitis, sinusitis, influenza, nasofaringitis, candidiasis de boca y garganta, infección de las vías urinarias, cefalea, tos, dolor bucofaríngeo, estreñimiento, artralgia, dolor de espalda.

Para más detalles sobre el perfil de seguridad del producto, dosis e indicaciones, consulte la información para prescribir completa aprobada en Colombia.

Referencias: 1. Información para prescribir Trelegy Eliipta aprobada en Colombia.



Información para prescribir Trelegy. (Registro Sanitario: INVIMA 2019M-0019227)

Esta información está dirigida exclusivamente a profesionales médicos en ejercicio legal de su profesión. Los pacientes y sus cuidadores deben consultar al médico o leer el inserto y la caja de producto para tener la información referente a los productos de venta bajo prescripción médica.

PM-CO-FVU-PPTX-250047 | Fecha de Elaboración: Octubre 2025

Material exclusivo para profesionales de la salud.

Información para prescribir completa disponible a solicitud | Referencia(s) disponible(s) a solicitud

Si usted desea mayor información o reportar una situación clínica desfavorable ocurrida durante el uso de un producto de GlaxoSmithKline, favor comunicarse al teléfono 01 8000 11 86 86 o escribir al correo electrónico: programa.dirmedica@gsk.com

Solicite mayor información científica de nuestros productos en nuestro servicio de información médica, a través del email mila@gsk.com

GlaxoSmithKline Colombia S.A., Avenida Calle 116 No. 7 - 15, Interior 2, Oficina 601A, Bogotá D.C.

El perfil de seguridad de TRELEGY se alinea con el de sus moléculas componentes individuales¹

Con base en la información para prescribir⁴

TRELEGY (FF/UMEC/VI) está indicado como tratamiento de mantenimiento en pacientes adultos con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) moderada a severa, quienes no están adecuadamente controlados con la combinación de un corticosteroide inhalado y un agonista beta-2 de acción prolongada o con la combinación de un agonista beta-2 de acción prolongada y un antagonista de receptor muscarínico de acción prolongada.

TRELEGY NO está indicado para el tratamiento del asma.

TRELEGY NO está indicado para los síntomas agudos de broncoespasmo.

No está indicado para el uso agudo

No existen datos clínicos que respalden el uso de TRELEGY para el tratamiento de episodios agudos de broncoespasmo o para tratar una exacerbación aguda de la EPOC (es decir, como terapia de rescate).

Deterioro de la enfermedad

El aumento del uso de broncodilatadores de acción corta para aliviar los síntomas puede indicar un deterioro del control de la enfermedad. En caso de deterioro de la EPOC durante el tratamiento con TRELEGY, se debe realizar una reevaluación del paciente y del régimen de tratamiento contra la EPOC.

Los pacientes no deben suspender el tratamiento con TRELEGY sin supervisión médica, ya que los síntomas pueden reaparecer después de la discontinuación.

Efectos cardiovascula-res

Se pueden observar efectos cardiovasculares, como arritmias cardíacas (p. ej., fibrilación auricular y taquicardia), después de la administración de antagonistas de los receptores muscarínicos y simpaticomiméticos, incluidos UMEC y VI, respectivamente. Por lo tanto, TRELEGY debe utilizarse con precaución en pacientes con enfermedad cardiovascular inestable o potencialmente letal.

EAs comunes (≥ 1/100 a <1/10):

Neumonía, infección de vías respiratorias superiores, bronquitis, faringitis, rinitis, sinusitis, influenza, nasofaringitis, candidiasis de boca y garganta, infección de las vías urinarias, cefalea, tos, dolor bucofaríngeo, estreñimiento, artralgia, dolor de espalda.

Otros eventos adversos importantes incluyen:

Poco comunes (≥1/1000 a <1/100): Taquiarritmia supraventricular, taquicardia, fibrilación auricular, disfonía, sequedad de boca, fracturas, infección viral del tracto respiratorio.

Efectos sistémicos:

Los efectos sistémicos pueden ocurrir con cualquier corticosteroide inhalado, particularmente en altas dosis prescritas por periodos prolongados. Existe mayor probabilidad de que estos efectos se presenten con corticosteroides orales.

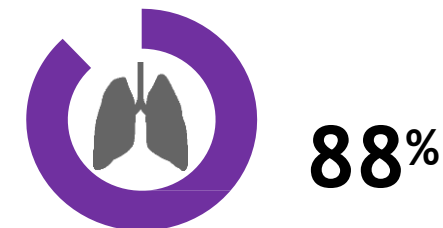
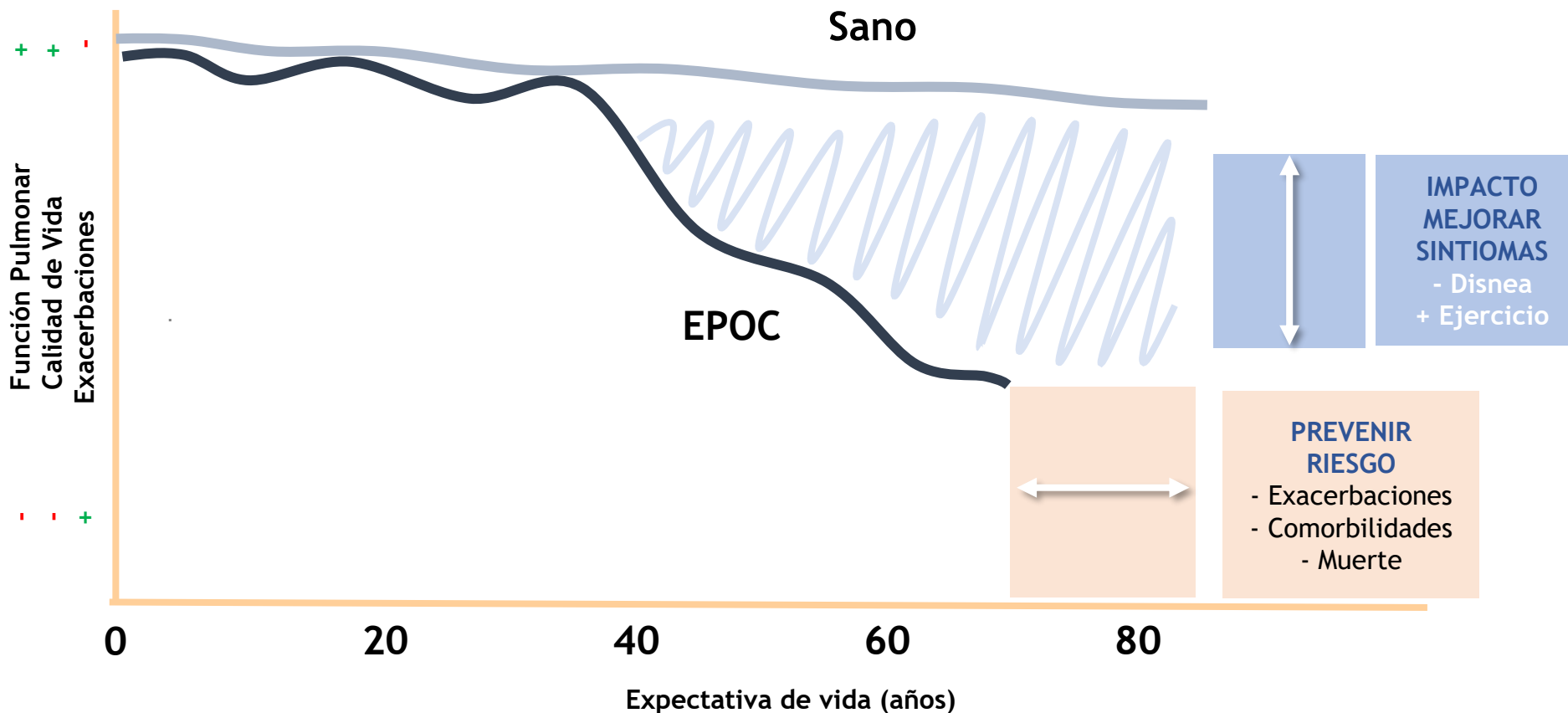
Neumonía

Se ha observado un aumento en la incidencia de neumonía, incluyendo neumonía que requiere hospitalización, en pacientes con EPOC que reciben corticosteroides inhalados.



Objetivos del tratamiento de la EPOC

Datos estimados de datos globales sumados de estadísticas comparativas



Persisten sintomáticos a pesar de recibir un LABA-CIs (CAT $\geq$ 10)

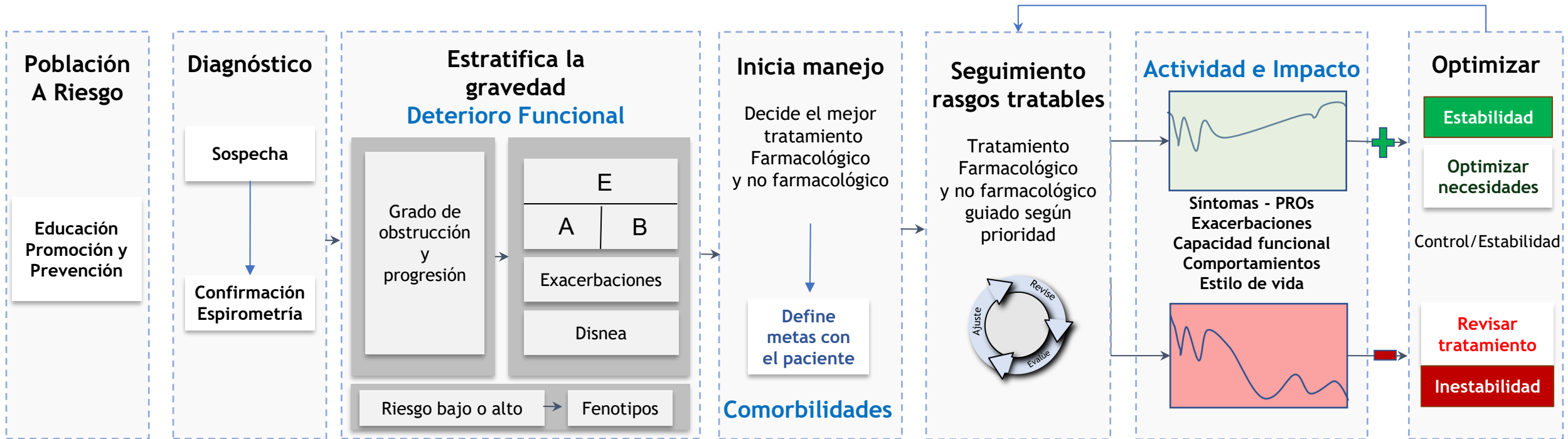


La mitad de los pacientes, persisten con disnea mMRC $\geq$ 2, a pesar del tratamiento



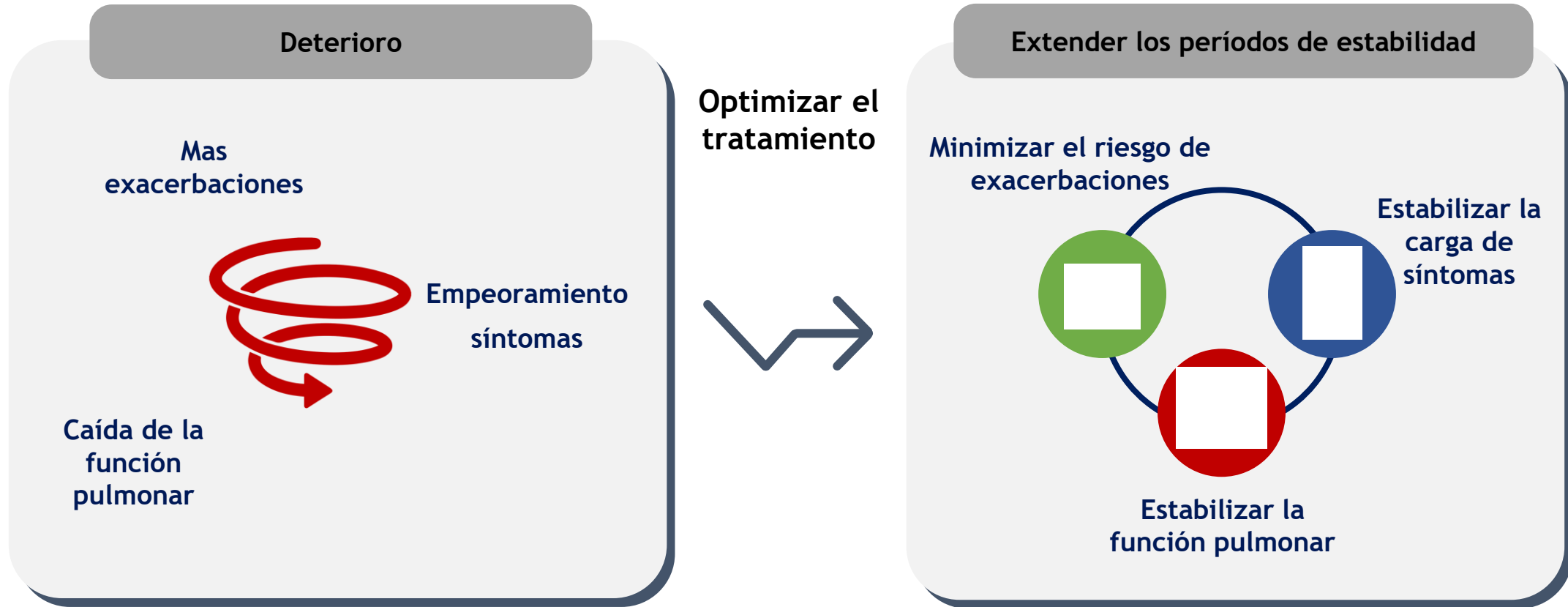
El 50% de tiene al menos una nueva exacerbación moderada severa, a pesar de LAMA-LABA.

Proceso atención en EPOC y deterioro clínico



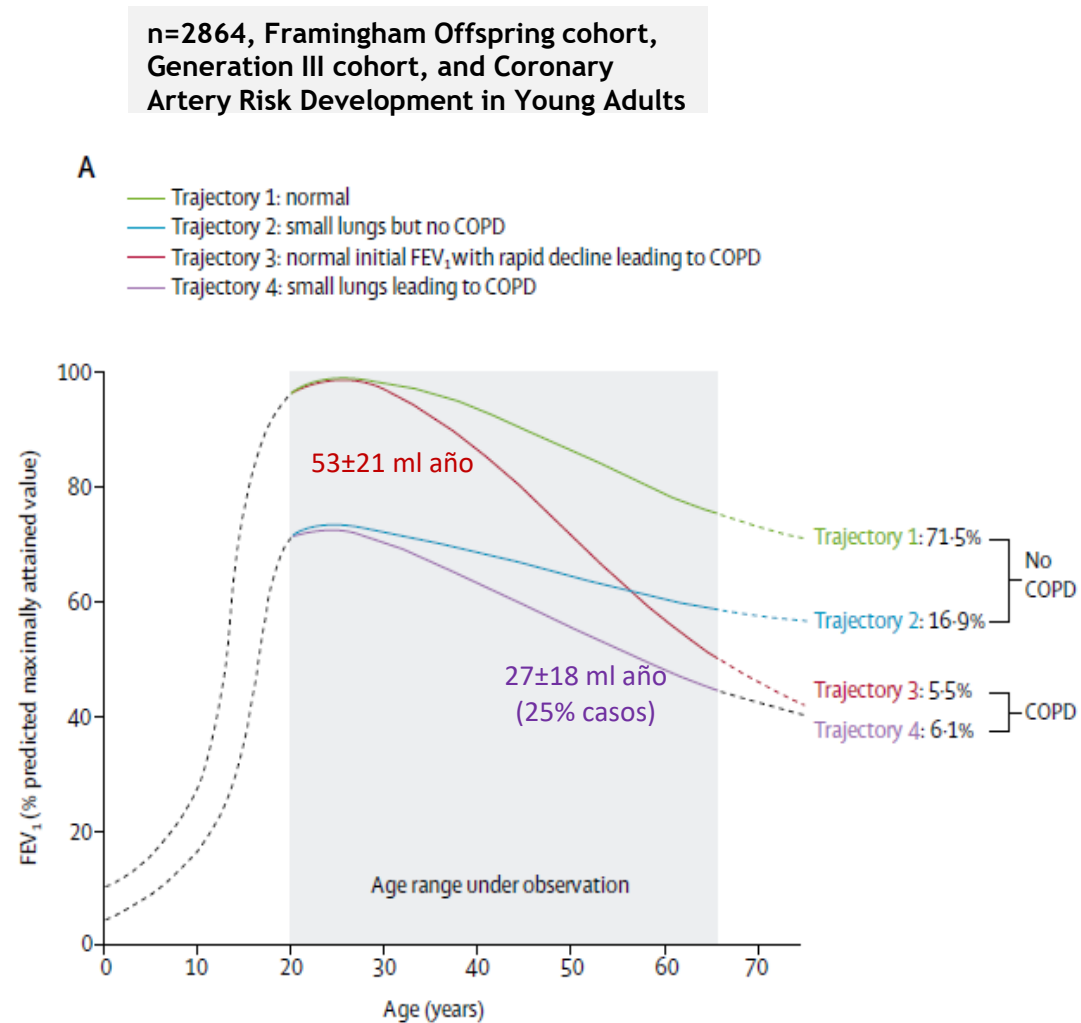
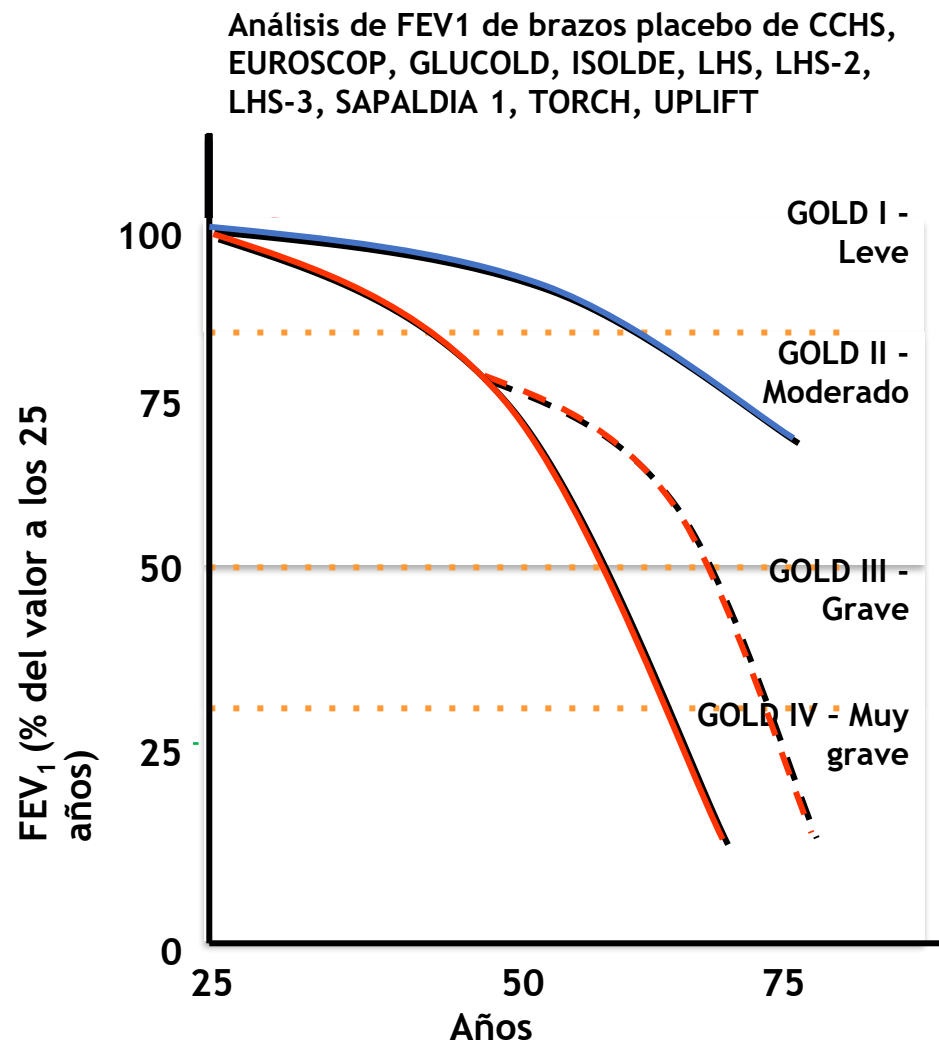
- ¿Es la naturaleza progresiva de la EPOC la que obliga una visión dinámica en el seguimiento?
- ¿Es la falta de marcadores biológicos la que impide un seguimiento individualizado de cada rasgo?
- ¿Qué variables utilizamos para catalogar un paciente como “estable” o “inestable”?
- ¿Presenciamos el deterioro de los pacientes, y llegamos tarde?

¿Debemos ser más ambiciosos para impactar los desenlaces?



Dada la naturaleza progresiva de la EPOC, nuestras expectativas han sido demasiado bajas
Los pacientes merecen períodos de estabilidad de la enfermedad el mayor tiempo posible.

¿Progresión de EPOC, la entendemos mejor, pero....que significa?



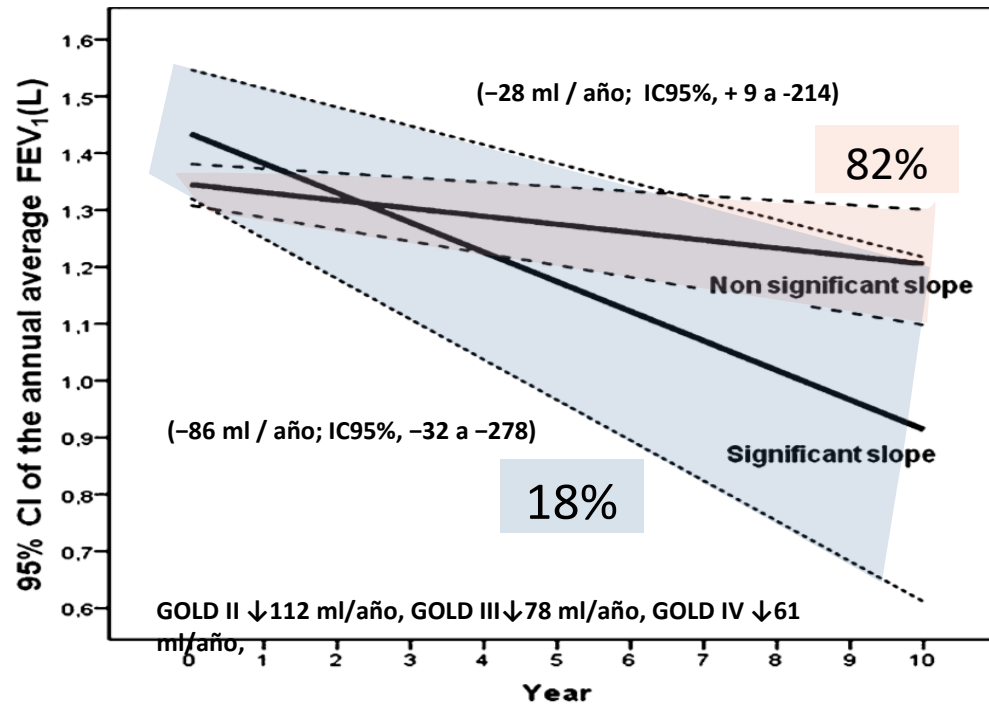
GOLD Definiciones EPOC - Progresión

- “COPD is a disease state characterized by airflow limitation that is not fully reversible. The airflow limitation is usually both progressive and associated with an abnormal inflammatory response of the lungs to noxious particles or gases” y el estadio 0 o en riesgo - GOLD 2001
- “Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a preventable and treatable disease with some significant extrapulmonary effects that may contribute to the severity in individual patients. Its pulmonary component is characterized by airflow limitation that is not fully reversible. The airflow limitation is usually progressive and associated with an abnormal inflammatory response of the lung to noxious particles or gases.” - Énfasis en otros factores de riesgo como el polvo y químicos ocupacionales, contaminación intradomiciliaria por combustión de biomasa en ambientes poco ventilados y sale estadio 0 GOLD 2006
- “COPD, a common preventable and treatable disease, is characterized by persistent airflow limitation that is usually progressive and associated with an enhanced chronic inflammatory response in the airways and the lung to noxious particles or gases. Exacerbations and comorbidities contribute to the overall severity in individual patients”. Y ABCD de tres variables : obstrucción+exacerbaciones+síntomas GOLD 2011
- “COPD is a common, preventable and treatable disease that is characterized by persistent respiratory symptoms and airflow limitation that is due to airway and/or alveolar abnormalities usually caused by significant exposure to noxious particles or gases”. Obstrucción separada de ABCD exacerbaciones + síntomas GOLD 2016 . Se quitó término progresiva
- “COPD as a heterogeneous lung condition characterized by chronic respiratory symptoms (dyspnea, cough, expectoration and/or exacerbations) due to abnormalities of the airways (bronchitis, bronchiolitis) and/or alveoli (emphysema) that cause persistent, often progressive airflow obstruction.”. Etipos, PRE-EPOC y Prism ; sin factor riesgo, ABE GOLD 2023

Progresión de EPOC en la vida real

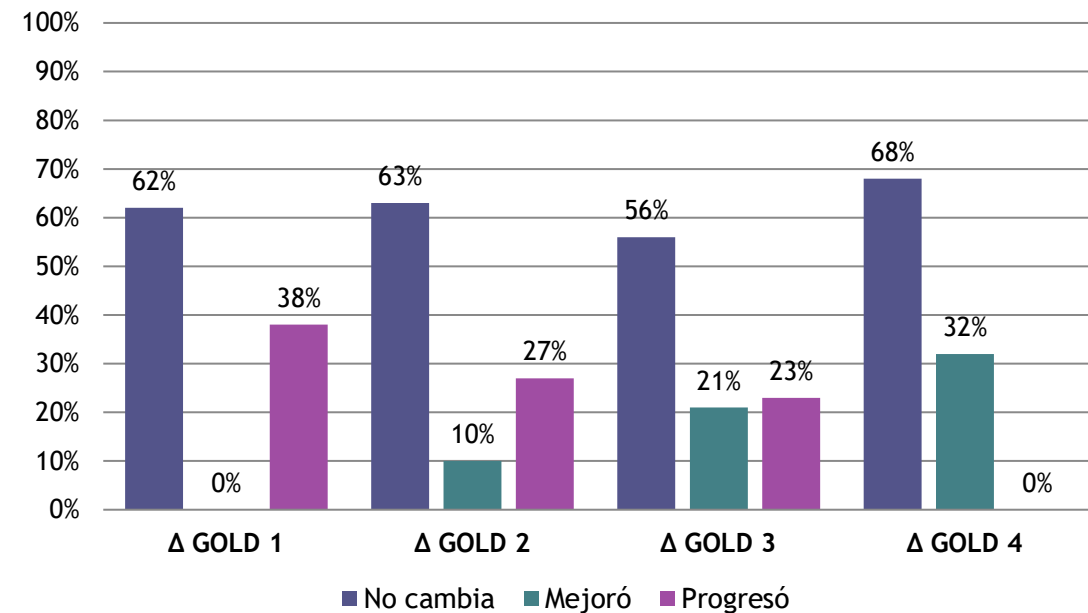
Cambios FEV₁ en una cohorte observacional BODE de la vida real

1198 pacientes, 64 m (prom) a 10 años, post β 2, BODE



Casanova C, et al. Am J Respir Crit Care Med 2011;184;1015

n=318, 8 años seguimiento cohorte BODE



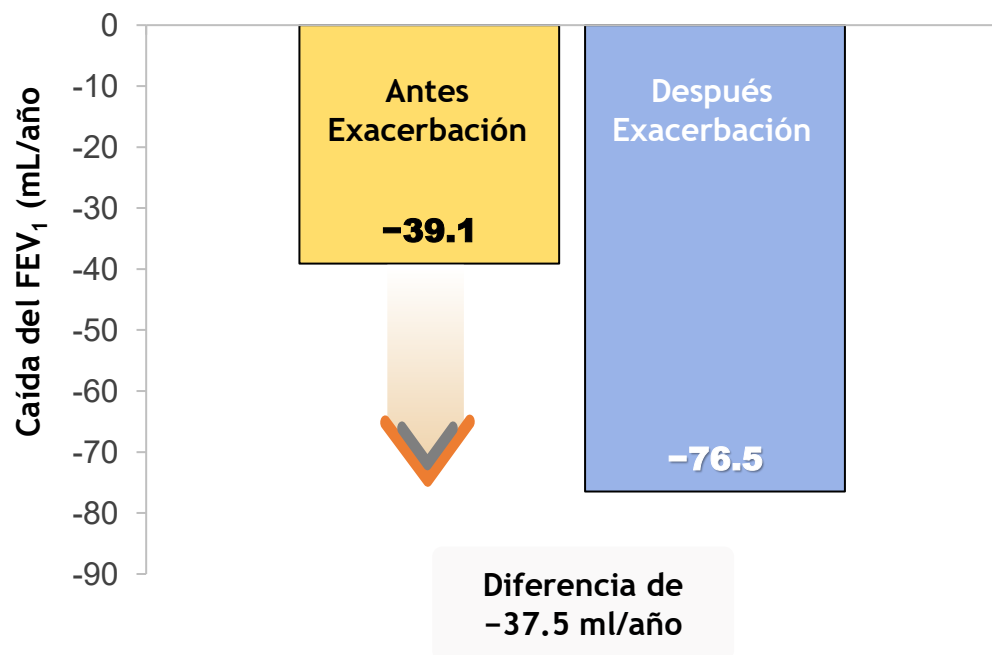
De Torres JP. PLOS ONE April 21, 2016

Progresión FEV₁ y exacerbaciones en pacientes con EPOC

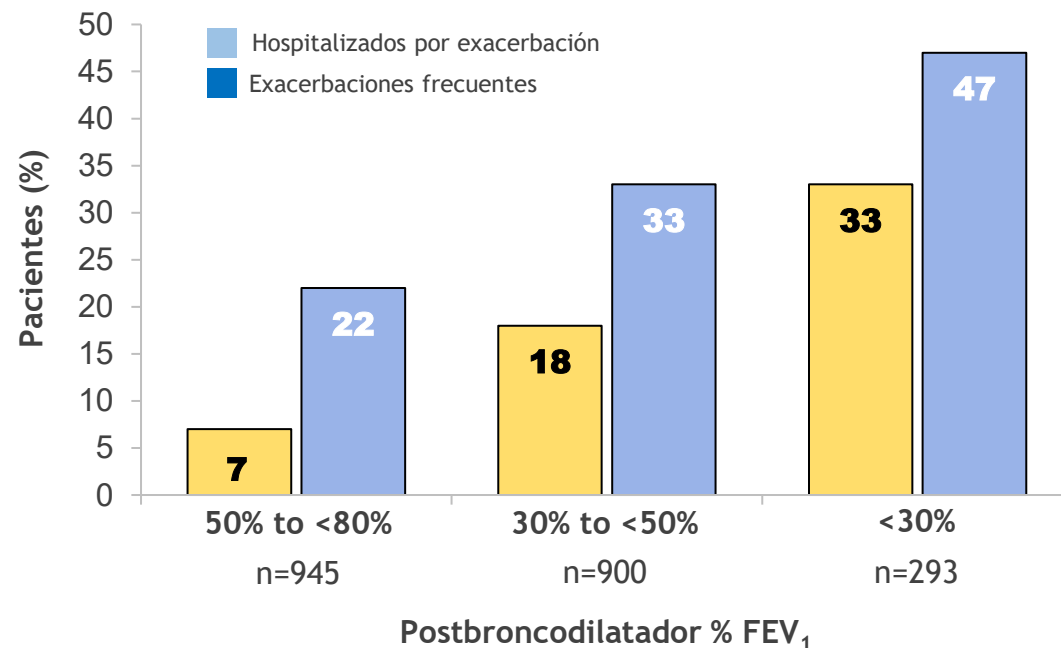
Una exacerbación moderada o severa y la caída de la función pulmonar - UPLIFT



A mayor grado de obstrucción, mayor frecuencia de exacerbaciones moderadas y severas - ECLIPSE



Halpin DMG, et al. *Respir Med.* 2017;128:85-91

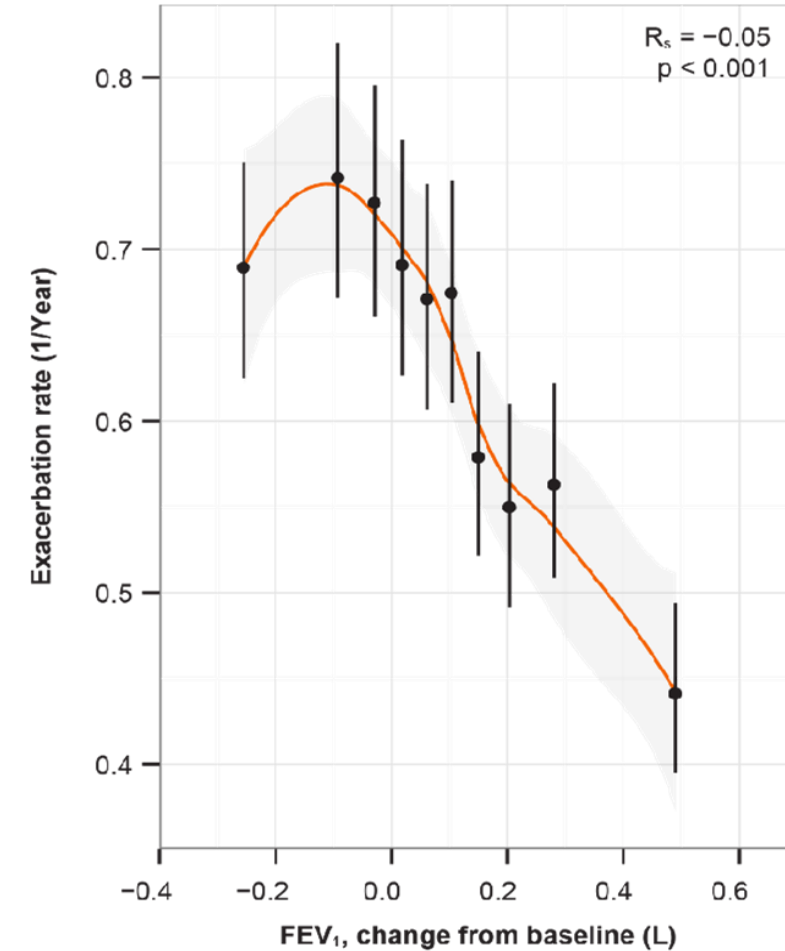
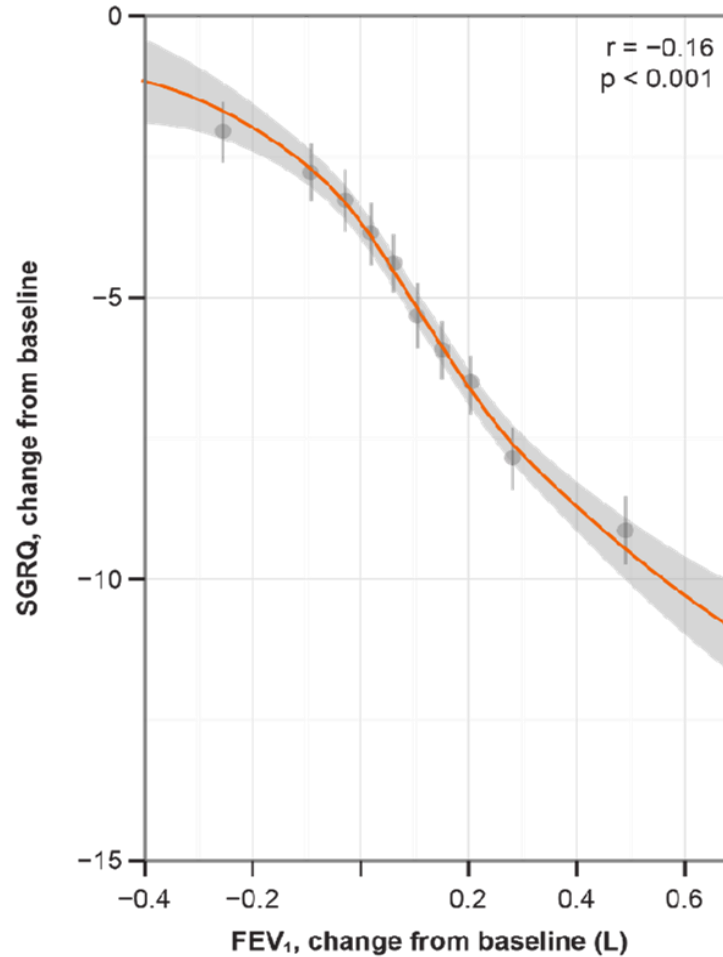


Hurst JR, et al. *N Engl J Med.* 2010;363(12):1128-1138

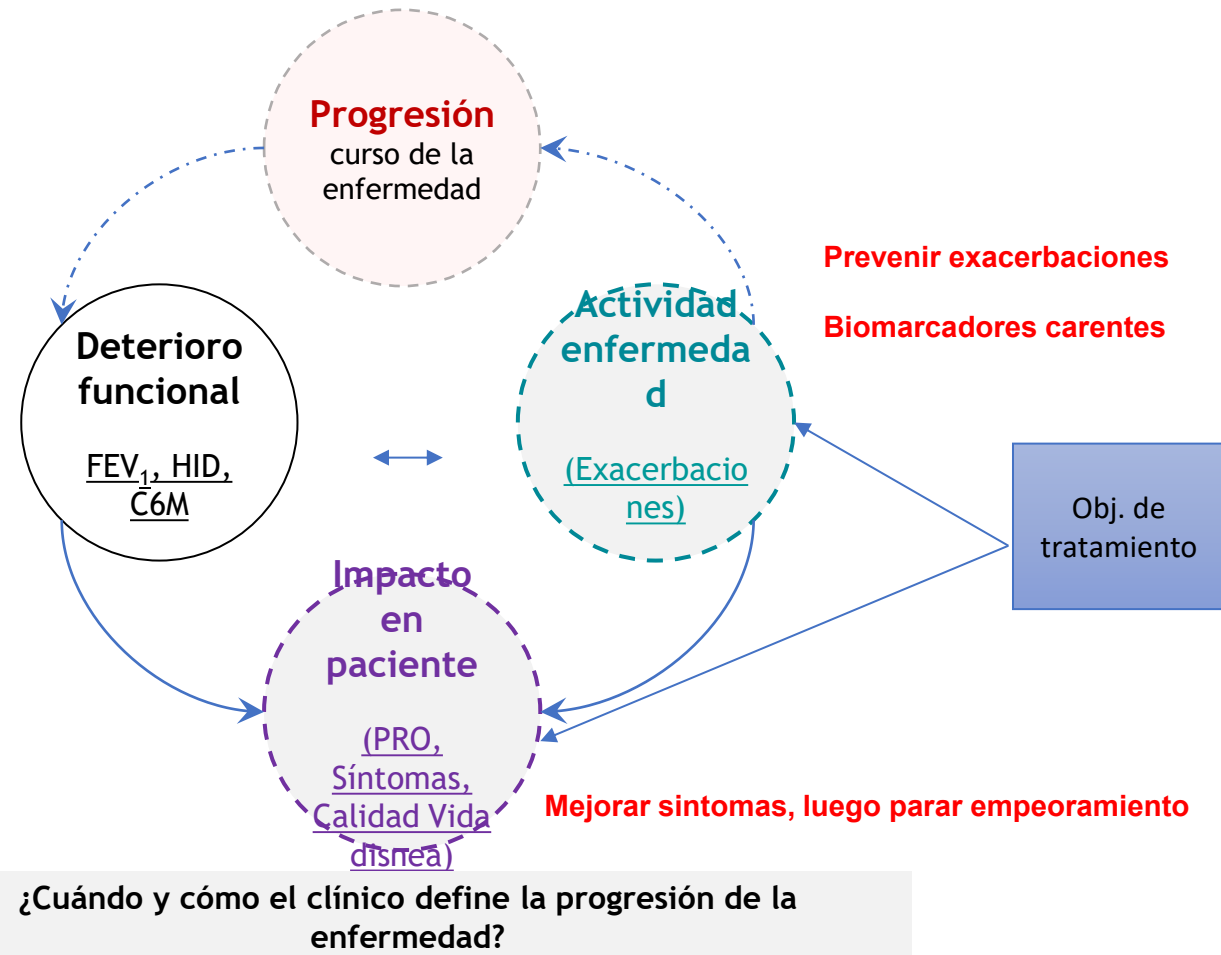
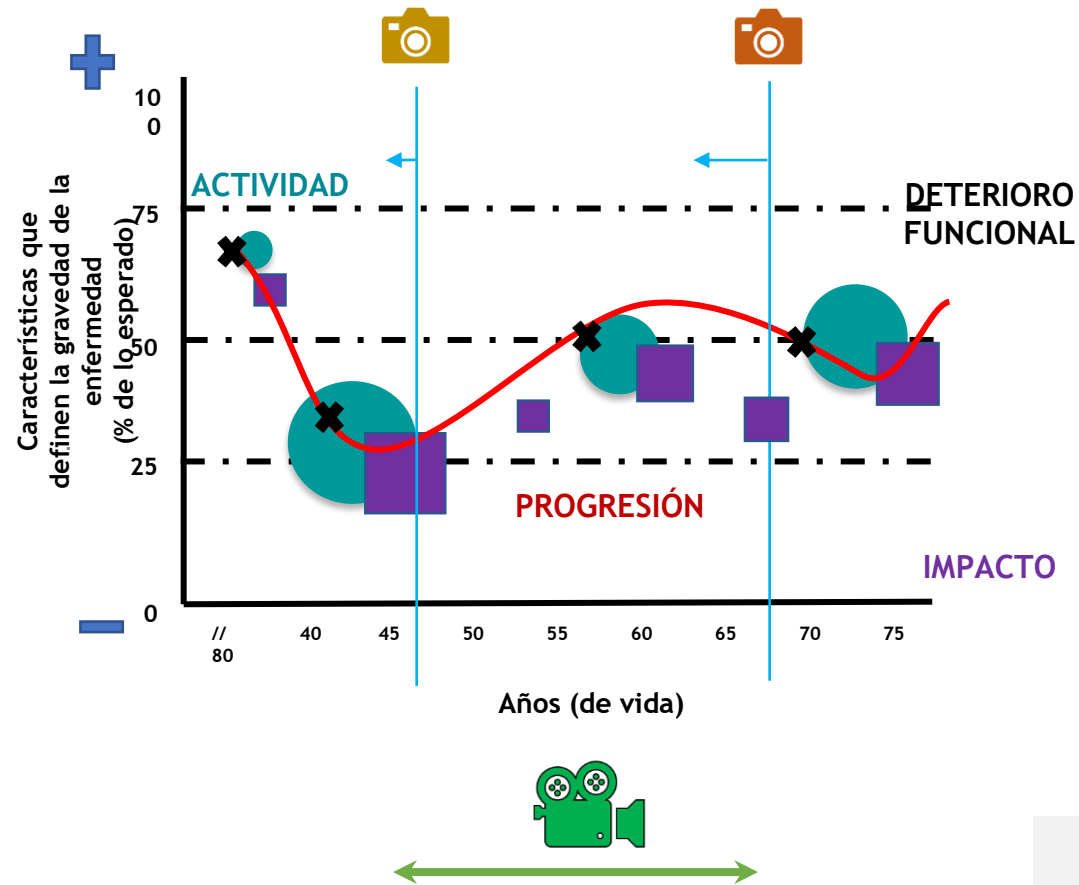
¿La mejoría del FEV₁ se correlaciona con mejores PROs?

Datos de estudios longitudinales (23 ECA, n = 23,213), en EPOC mostraron que los pacientes con una mejoría del FEV₁ tenían:

- mejores puntajes SGRQ y TDI
- menos exacerbaciones
- menor uso de medicación de rescate



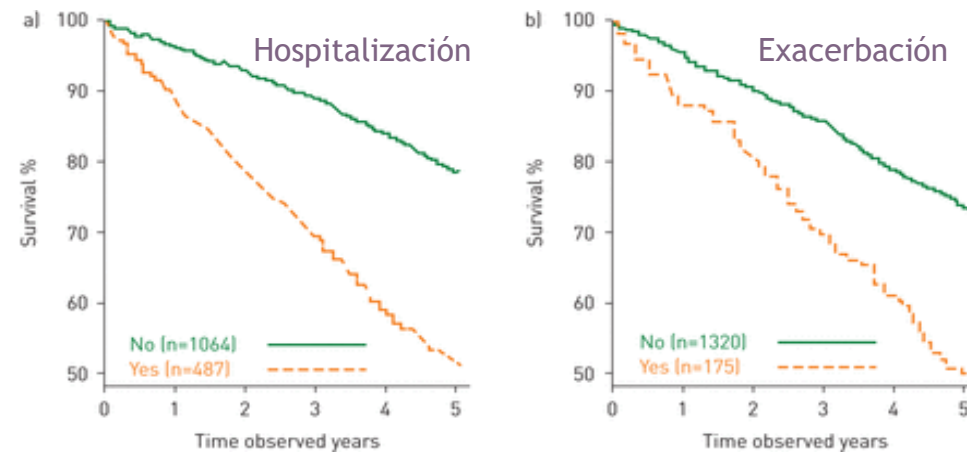
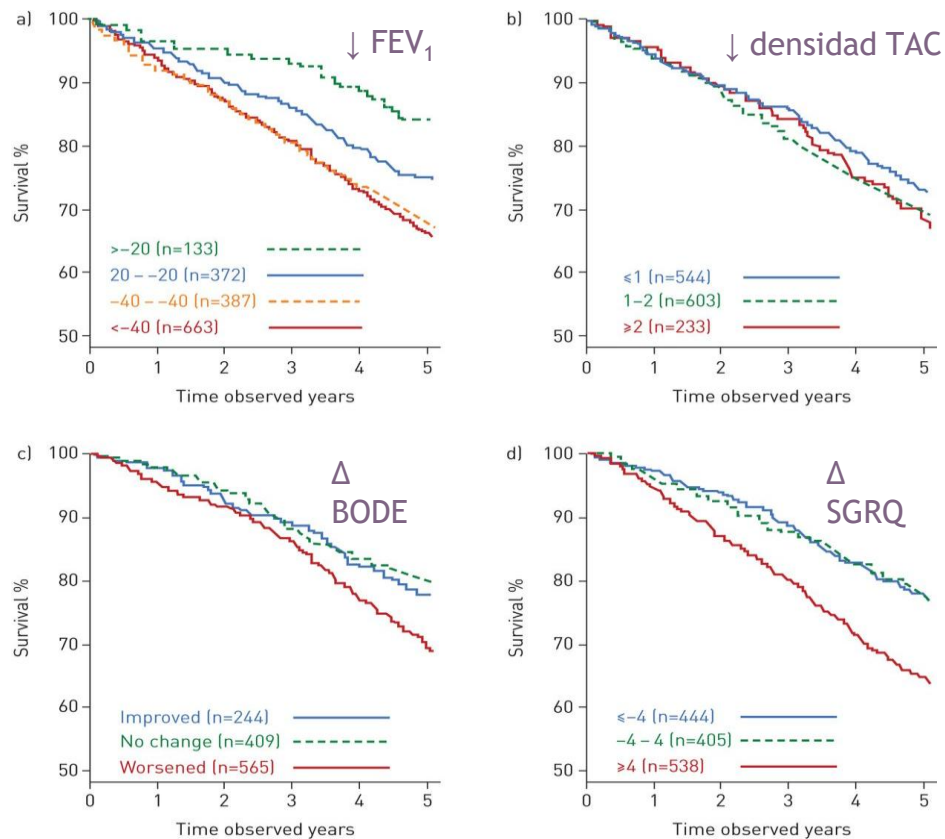
Entender actividad, impacto, gravedad y progresión en EPOC



ECLIPSE: Marcadores validados de actividad e impacto

¿Estaremos midiendo las variables correctas que miden progresión de la EPOC?

Cohorte ECLIPSE, cambios variables entre 1 y 3 años como predictor de mortalidad a 8 años, n=2164 (89% vivos 3 a) y a 8 años n=1555 (80,4%)



- Todos fueron predictores de muerte a 8 años y por ello marcadores sustitutos de actividad e impacto de la enfermedad
- Los cambios fueron independientes entre sí, y ninguna variable por si sola, puede explicar la progresión y el pronóstico

Estabilidad de la enfermedad y enfoque personalizado de la atención.



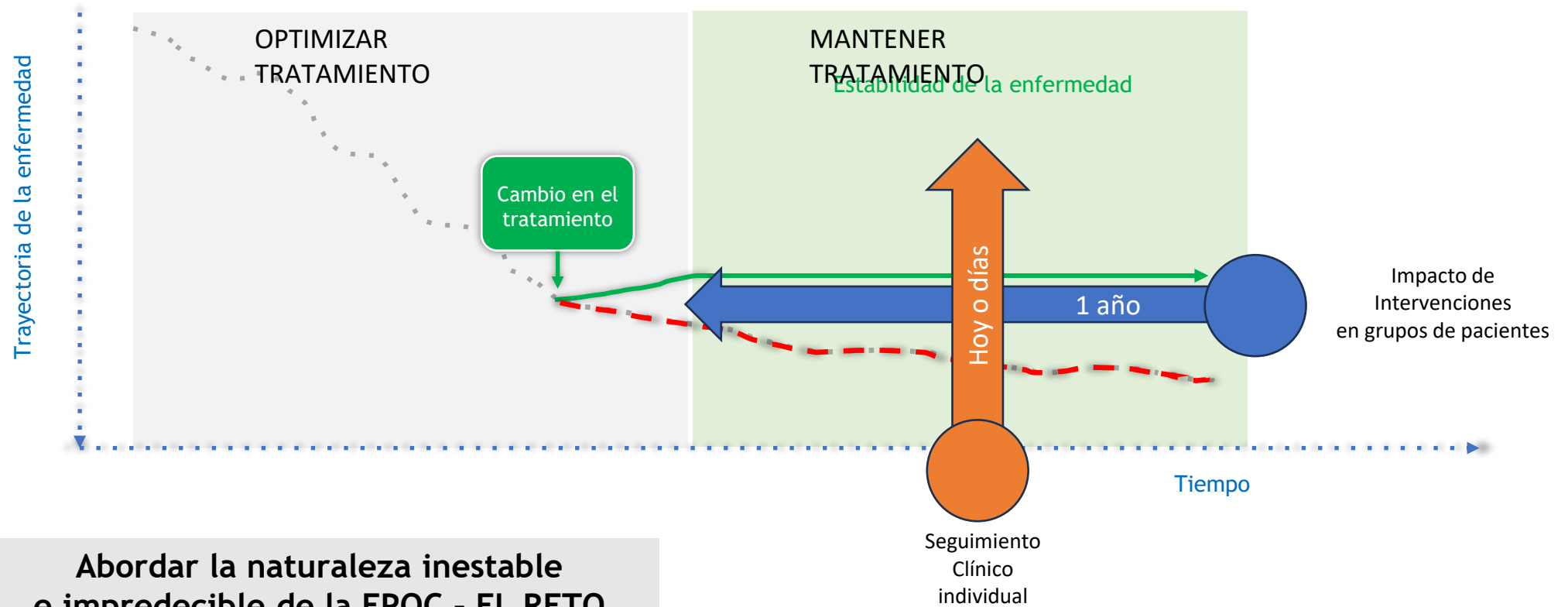
La **estabilidad clínica** de la enfermedad describe un estado en el que hay una mejora, ningún cambio o un empeoramiento mínimo de las medidas clínicas clave, tanto por separado como combinadas durante un período clínicamente relevante.

¿Estabilidad clínica y control de la progresión son sinónimos?

Progresión (estabilidad o deterioro)

Impacto grupos de pacientes vs impacto individual

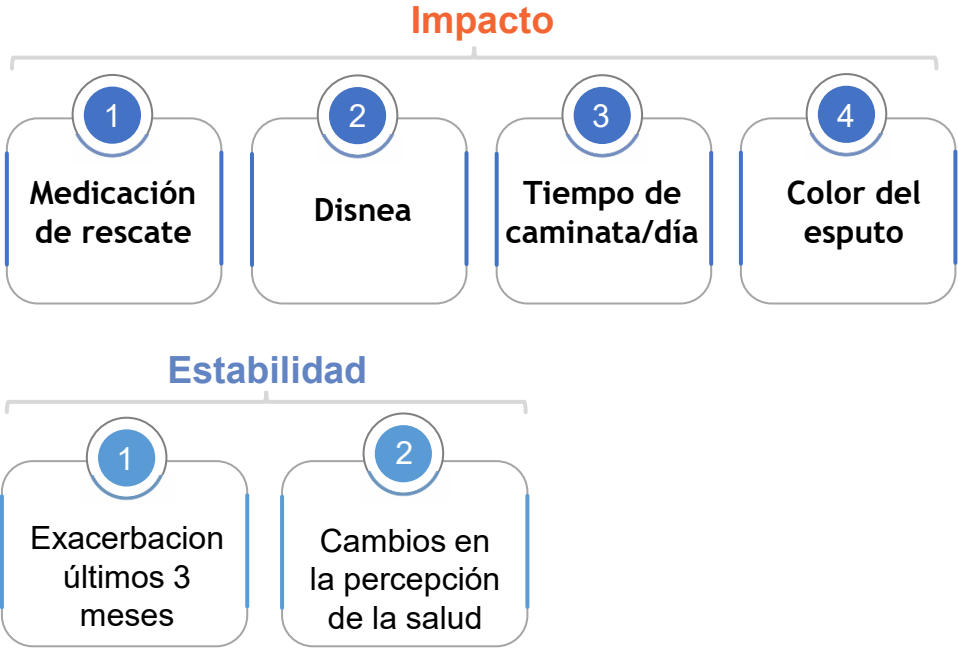
La estabilidad debe ser un objetivo terapéutico alcanzable en todos los estadios de la enfermedad



Abordar la naturaleza inestable e impredecible de la EPOC - EL RETO

El CONTROL CLÍNICO describe el impacto actual y en el tiempo

El control clínico se define como de bajo impacto y estabilidad en base a seis dominios clave



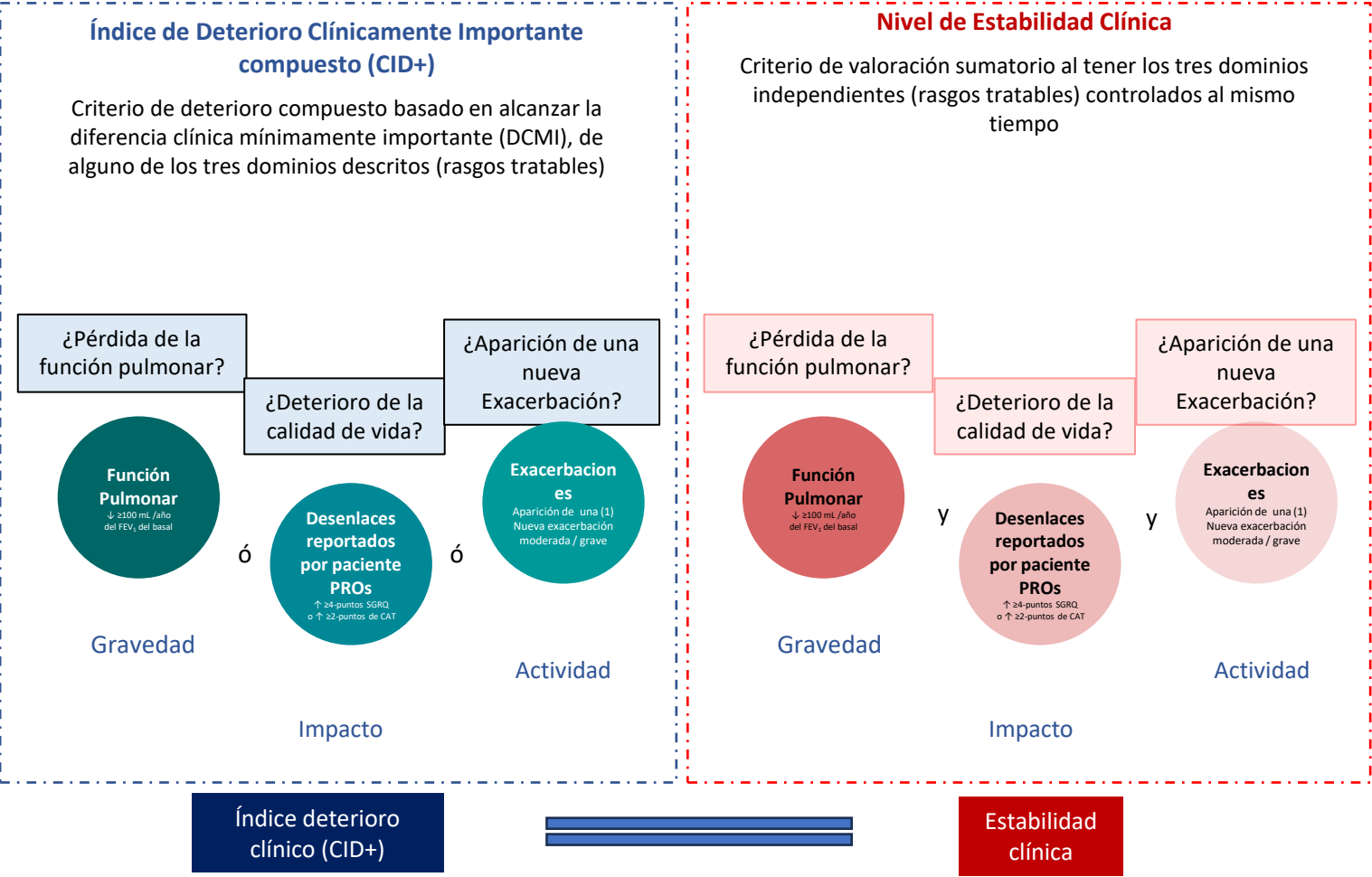
Existen umbrales predefinidos para cuantificar la mejoría de los síntomas y prevenir su empeoramiento

Criterios de control clínico que determinan el impacto clínico en EPOC

	EPOC leve a moderada*	Grave/muy EPOC grave†
Disnea (mMRC)	0–1	0–2
Medicación de rescate	≤3 veces última semana	≤2 veces al día
Actividad física diaria (tiempo caminado por día)	≥60 minutos	≥30 minutos
Color del esputo	Ausente o blanco	Ausente o blanco
Cuestionarios de control clínico		
CAT	≤10	≤20
CCQ	≤1	≤2

Soler-Cataluña JJ et al. *Int J Chron Obstruct Pulmon Dis* 2014;9:1397-1405; 2. Miravittles M et al. *Arch Bronconeumol* 2022;58:69-81.

¿Cómo medir la estabilidad clínica?



Control Clínico de EPOC

Cuestionario de control clínico en la EPOC®

Estabilidad

E₁ ¿Cómo se encuentra usted desde la última visita?

☐ Mejor ☐ Igual ☐ Peor

E₂ ¿Ha presentado alguna agudización en los últimos 3 meses?

☐ No ☐ Sí

☐ Estable (Se deben cumplir los dos criterios)

☐ Inestable (Si se cumple cualquiera de los criterios)

Impacto

I₁ ¿Cuál es el color del esputo de los últimos días?

☐ Blanco / limpio o sin esputo ☐ Oscuro / Sucio

I₂ ¿Cuántas veces utilizó la medicación de rescate en la última semana? (Por las ocasiones que precisa la medicación de rescate, con independencia del número de inhalaciones que utilice cada vez)

☐ < 3 veces / semana ☐ ≥ 3 veces / semana

I₃ ¿Cuánto tiempo (en promedio) ha paseado al día en la última semana?

☐ ≥ 30 minutos al día ☐ < 30 minutos al día

I₄ ¿Cuál es el grado de disnea actual (escala mMRC)?

FEV₁ ≥ 50% FEV₁ < 50% FEV₁ ≥ 50% FEV₁ < 50%

☐ Disnea 0 - 1 ☐ Disnea 0 - 2 ☐ Disnea ≥ 2 ☐ Disnea ≥ 3

☐ Bajo impacto (Se deben cumplir 3 de los 4 criterios)

☐ Alto impacto (Si se cumplen al menos 2 criterios)

☐ Grado 0: Ausencia de disnea excepto al realizar ejercicio intenso

☐ Grado 1: Disnea al andar deprisa en llano, o al subir una pendiente poco pronunciada

☐ Grado 2: La disnea imposibilita mantener el paso de otras personas de la misma edad caminando en llano, u obliga a detenerse o descansar al andar en llano al propio paso

☐ Grado 3: al andar en llano menos de 100 metros

☐ Grado 4: La disnea impide al paciente salir de casa o aparece con actividades como vestirse o desvestirse

Control

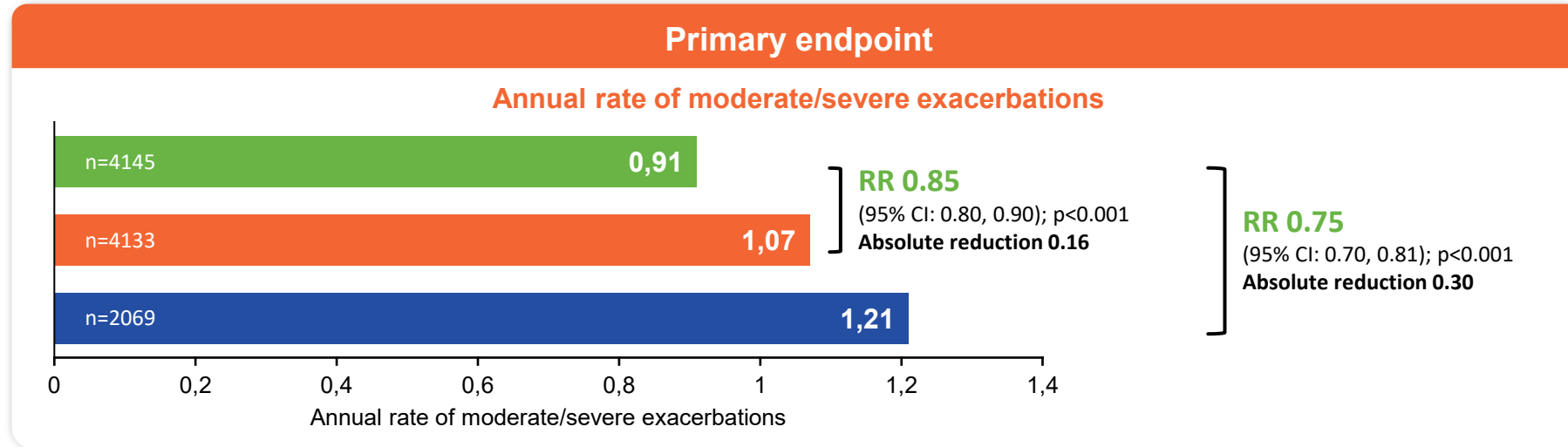
Estabilidad ☐ + ☐ Bajo impacto

☐ Control (Se deben cumplir los dos criterios)

Inestabilidad ☐ O ☐ Alto impacto

☐ No control (Si se cumple cualquiera de los criterios)

IMPACT*: FF/UMEC/VI muestra beneficios clinicos vs FF/VI y UMEC/VI*1



FF/UMEC/VI FF/VI UMEC/VI

Exacerbation risk - 25% reduction

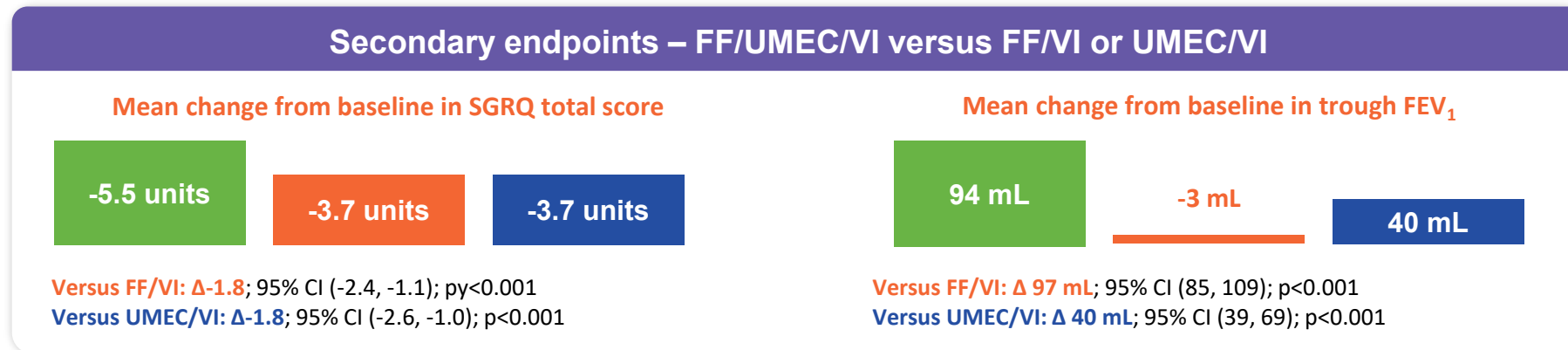
in the annual rate of moderate/severe exacerbations vs UMEC/VI. (At Week 52; ARR: 0.30; 0.91/year vs 1.21/year, respectively; RR 0.75, 95% CI: 0.70, 0.81; p<0.001)¹

Lung function - 54 mL greater

lung function improvement vs UMEC/VI. (CFB in trough FEV₁ at Week 52, +94 mL vs +40 mL, respectively; 95% CI: 39, 69; p<0.001)¹

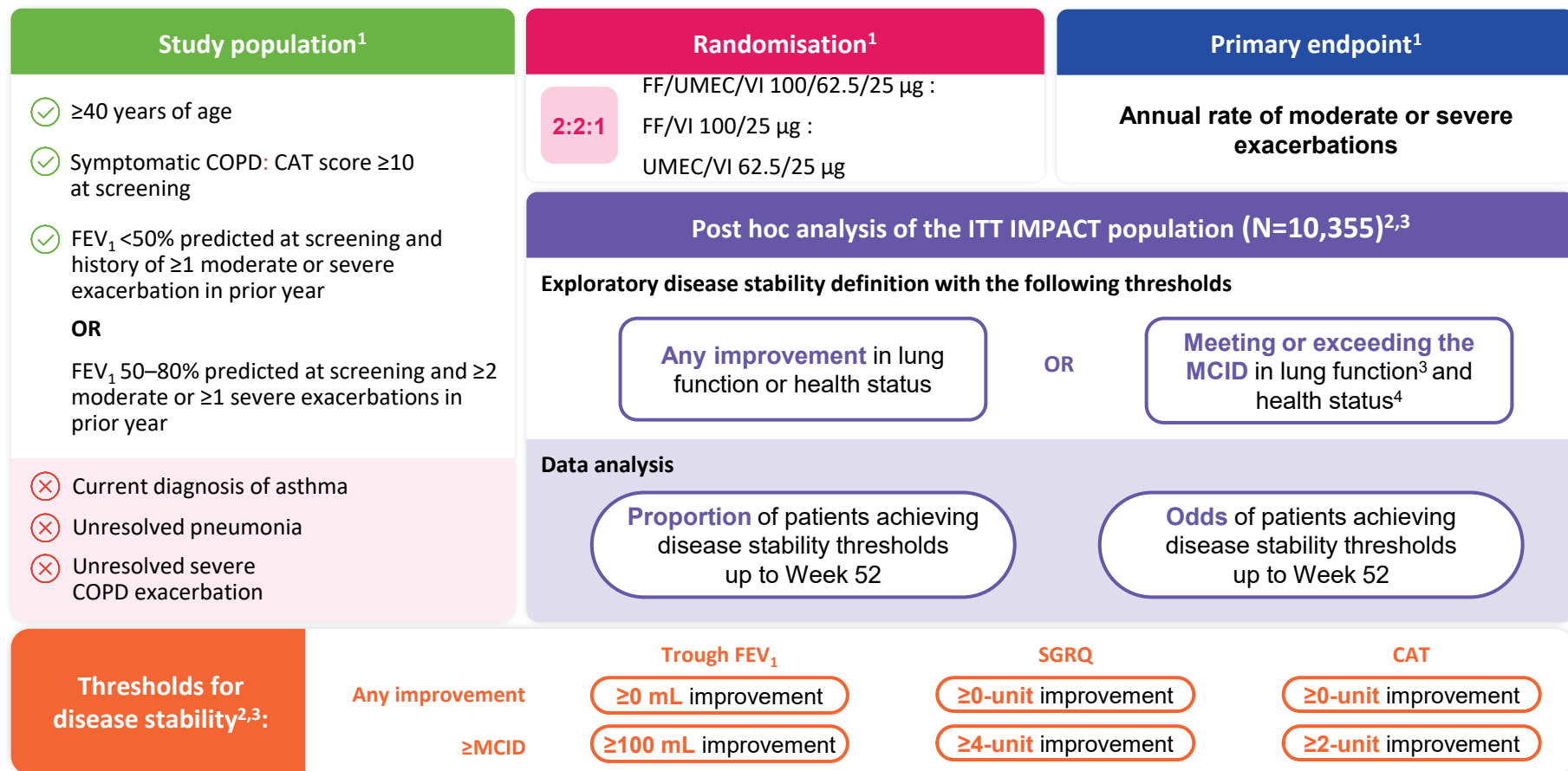
Symptom control - 1.8 greater

symptom reduction on SGRQ vs UMEC/VI (At Week 52, -5.5 vs -3.7 CFB, respectively; OR - 1.8, 95% CI: -2.6, -1.0; p<0.001)¹



*The IMPACT trial was a Phase 3 RCT involving 10,355 patients with COPD with primary objective to evaluate the effects of 52 weeks of a once-daily combination of FF/UMEC/VI compared with UMEC/VI and FF/VI on the rate of moderate/severe exacerbations.¹ ARR, absolute rate reduction; CFB, change from baseline; CI, confidence interval; COPD, chronic obstructive pulmonary disease; FEV₁, forced expiratory volume in 1 second; FF, fluticasone furoate; ITT, intention-to-treat; OR, odds ratio; RCT, randomised controlled trial; RR, rate ratio; SGRQ, St George's Respiratory Questionnaire; UMEC, umecclidinium; VI, vilanterol. 1. Lipson DA, *et al. N Engl J Med* 2018;378:1671–1680.

Umbrales para estabilidad: Post hoc de IMPACT trial

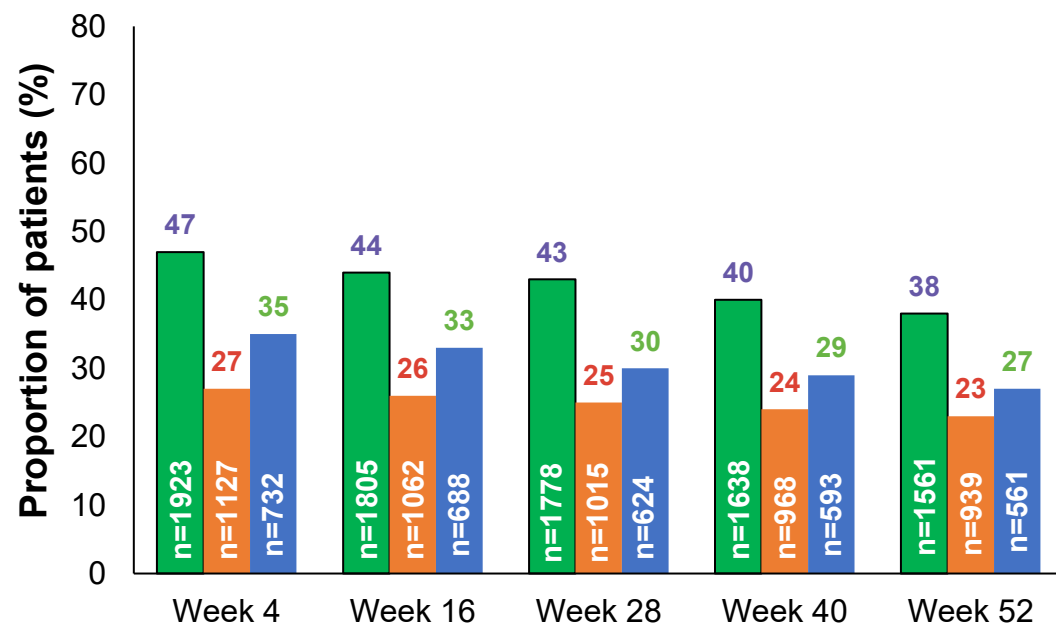


CAT, COPD Assessment Test; COPD, chronic obstructive pulmonary disease; FEV₁, forced expiratory volume in 1 second; FF, fluticasone furoate; ITT, intent-to-treat; MCID, minimal clinically important difference; SGRQ, St George's Respiratory Questionnaire; UMEC, umeclidinium; VI, vilanterol.

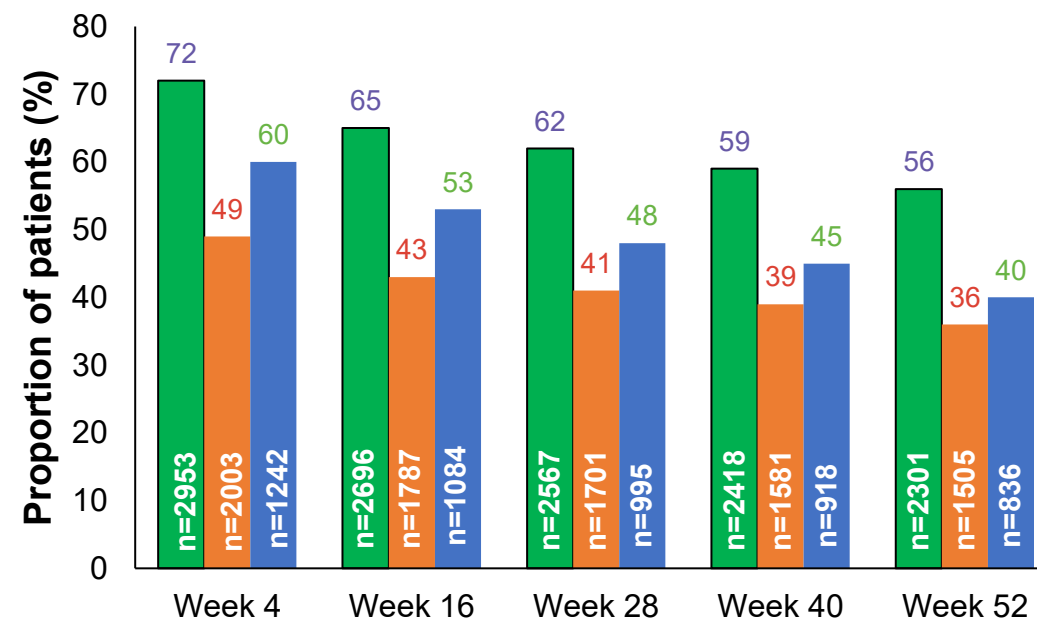
1. Lipson DA et al. N Engl J Med. 2018;378:1671–80; 2. Halpin DMG et al. Presented at ERS 2024. OA4653; 3. Halpin DMG et al. Presented at ERS 2024. Poster PA1173.

Estabilidad del FEV1 (>100 o No cambio) FF/UMEC/VI vs doble terapia – Análisis post hoc - IMPACT

% de pacientes que lograron una mejoría de ≥ 100 mL desde el inicio en el FEV1 valle



% de pacientes que lograron una mejoría de ≥ 0 mL/sin cambios desde el inicio en el FEV1 valle.

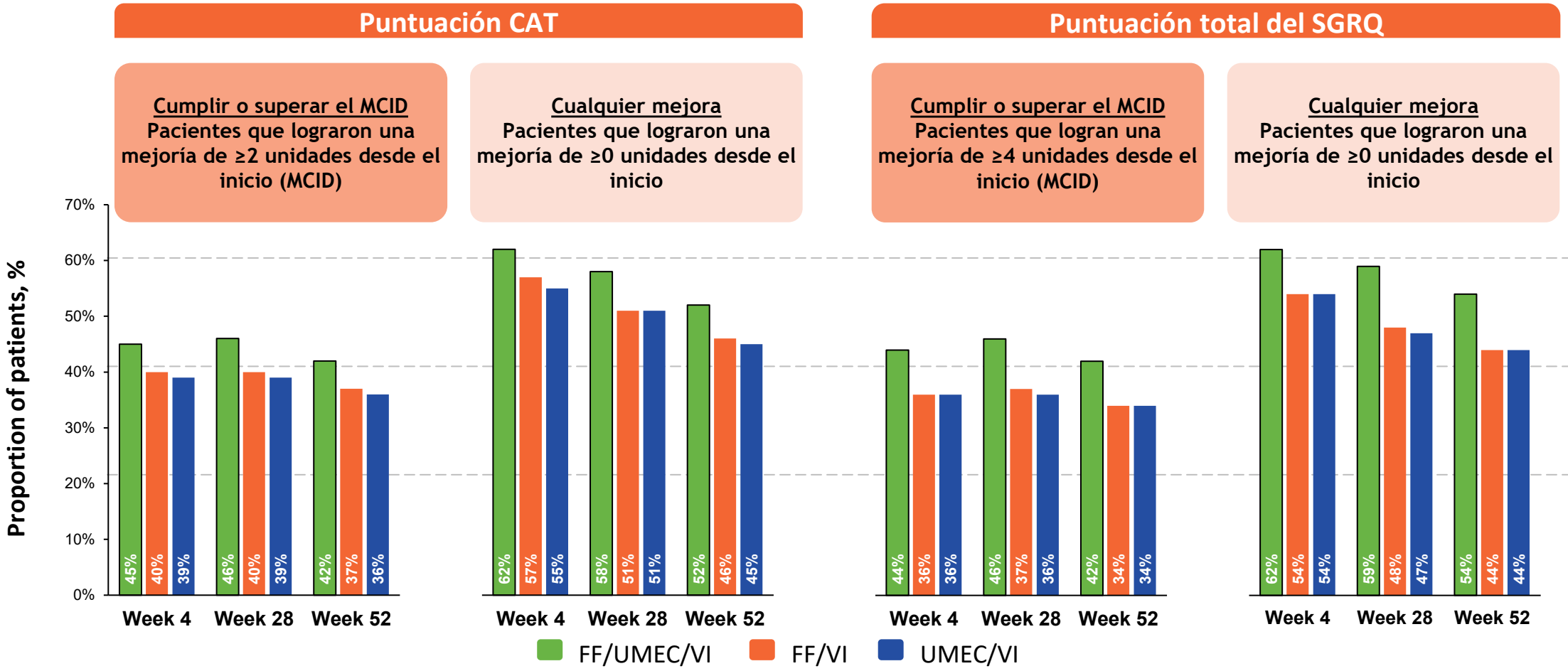


■ FF/UMEC/VI (N=4151)
 ■ FF/VI (N=4134)
 ■ UMEC/VI (N=2070)

Una mayor proporción de pacientes lograron la estabilización de la función pulmonar con FF/UMEC/VI vs terapia dual, independientemente del umbral utilizado

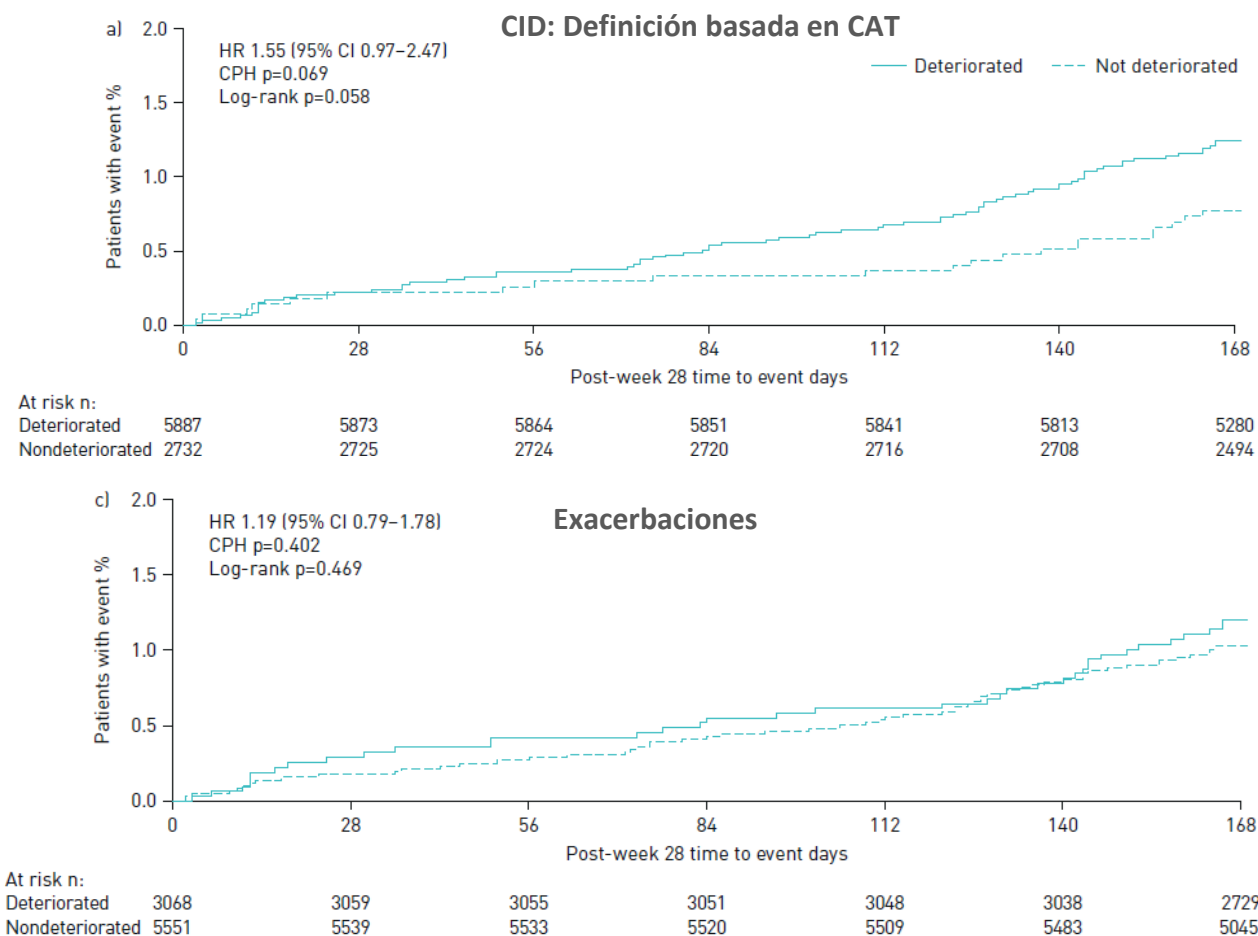
Estabilización SGRQ y CAT con FF/UMEC/VI FF/UMEC/VI vs doble terapia

Análisis post hoc - IMPACT



El Deterioro clínicamente importante (CID+)

Mejor predictor de mortalidad que exacerbaciones en IMPACT

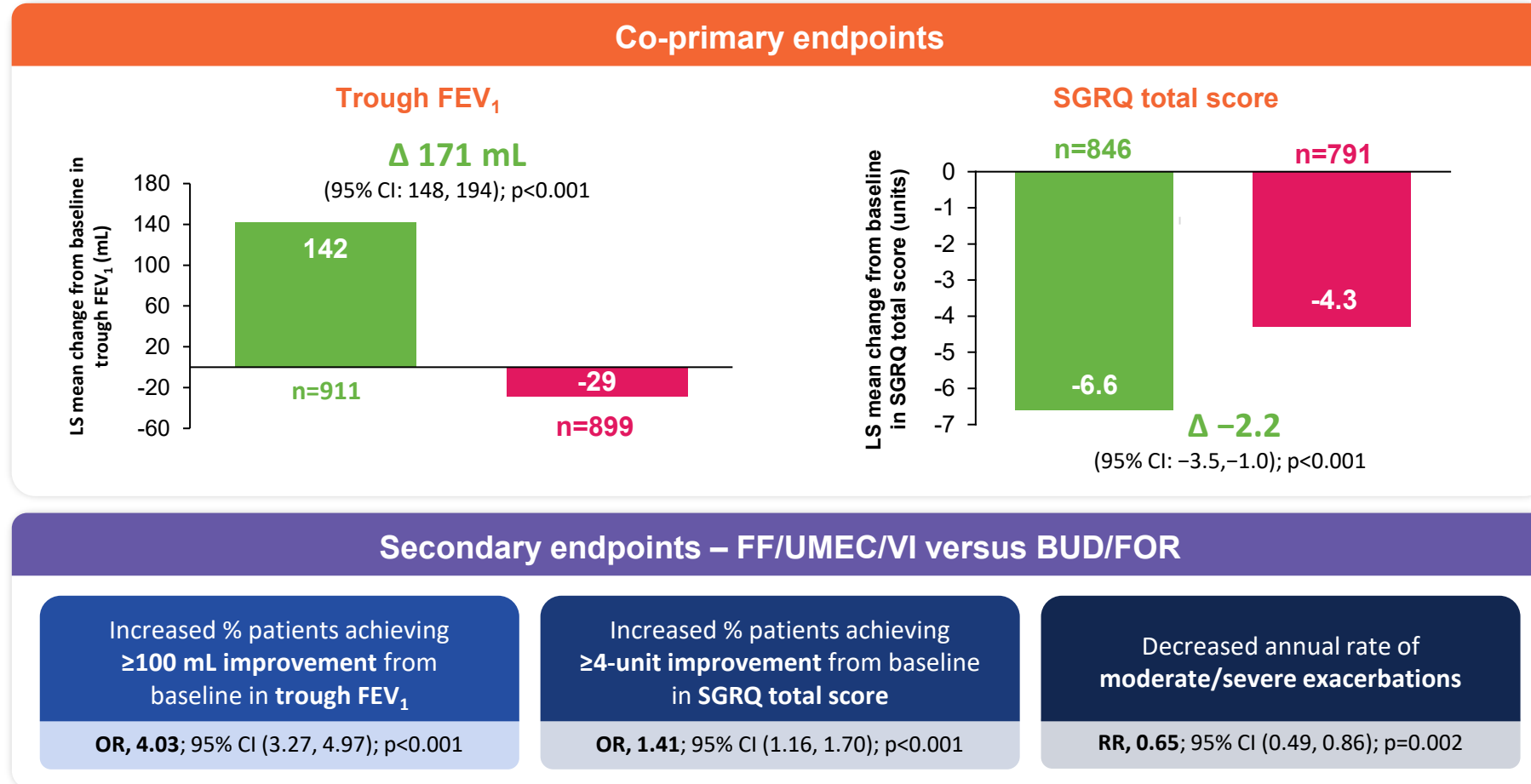


- ✓ IMPACT
- ✓ Estudio prospectivo, 52 semanas comparando FF/UMEC/VI con FF/VI y UMEC/VI en pacientes sintomáticos y con historia reciente de exacerbaciones.
- ✓ Tiempo hasta la muerte por todas las causas con / sin tratamiento después de la semana 28 por CID o exacerbación usando la definición basada en CAT (CID^{CAT}) y solo exacerbación moderada/grave

Análisis Post Hoc de IMPACT:
El CID+ es mejor predictor de mortalidad que la presencia de exacerbaciones.



FULFIL*: FF/UMEC/VI mejora significativamente los desenlaces vs BUD/FOR*¹



FF/UMEC/VI BUD/FOR

Symptom control - 59% greater

odds of symptom relief (by E-RS) vs BUD/FOR (At Weeks 21–24, 47% vs 37%, respectively; OR: 1.59; 95% CI: 1.30, 1.94; p<0.001)^{1,2}

Lung function - 171 mL greater

(CFB in trough FEV₁ at Week 24, 95% CI: 148, 194; p<0.001; FF/UMEC/VI +142 mL, BUD/FOR -29 mL)¹

Exacerbation risk - 44% reduction

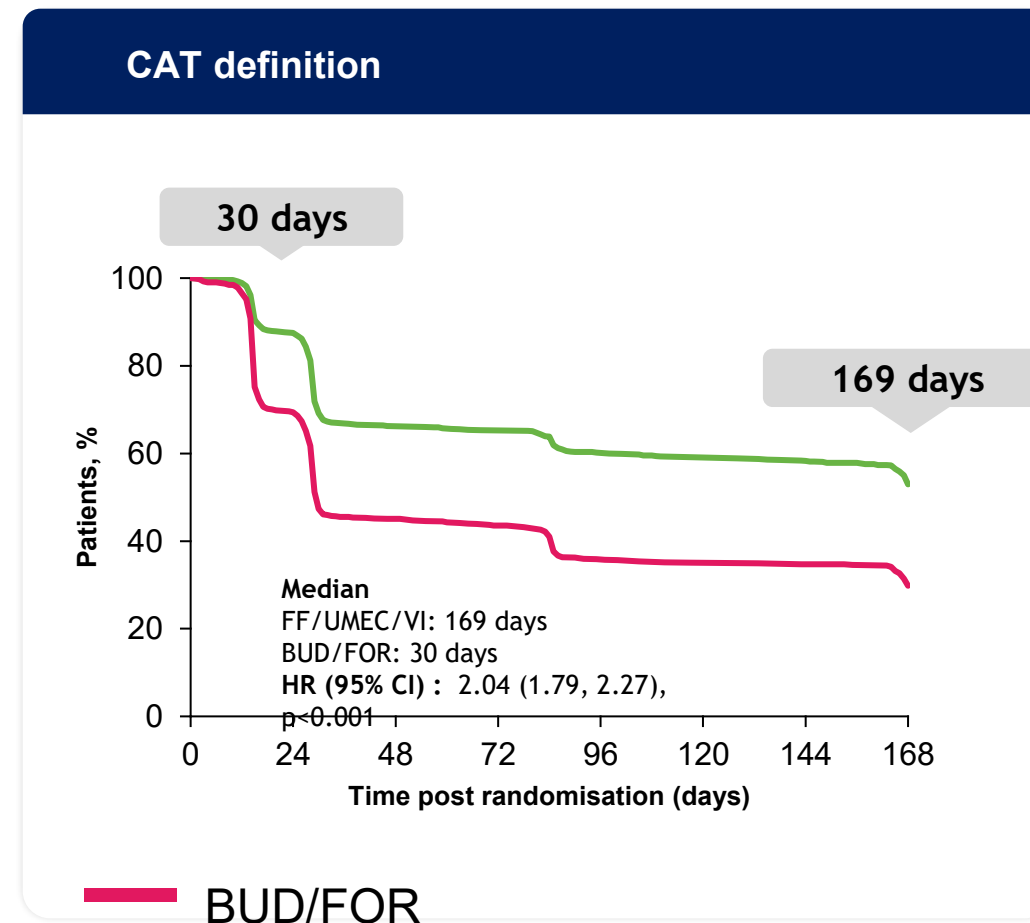
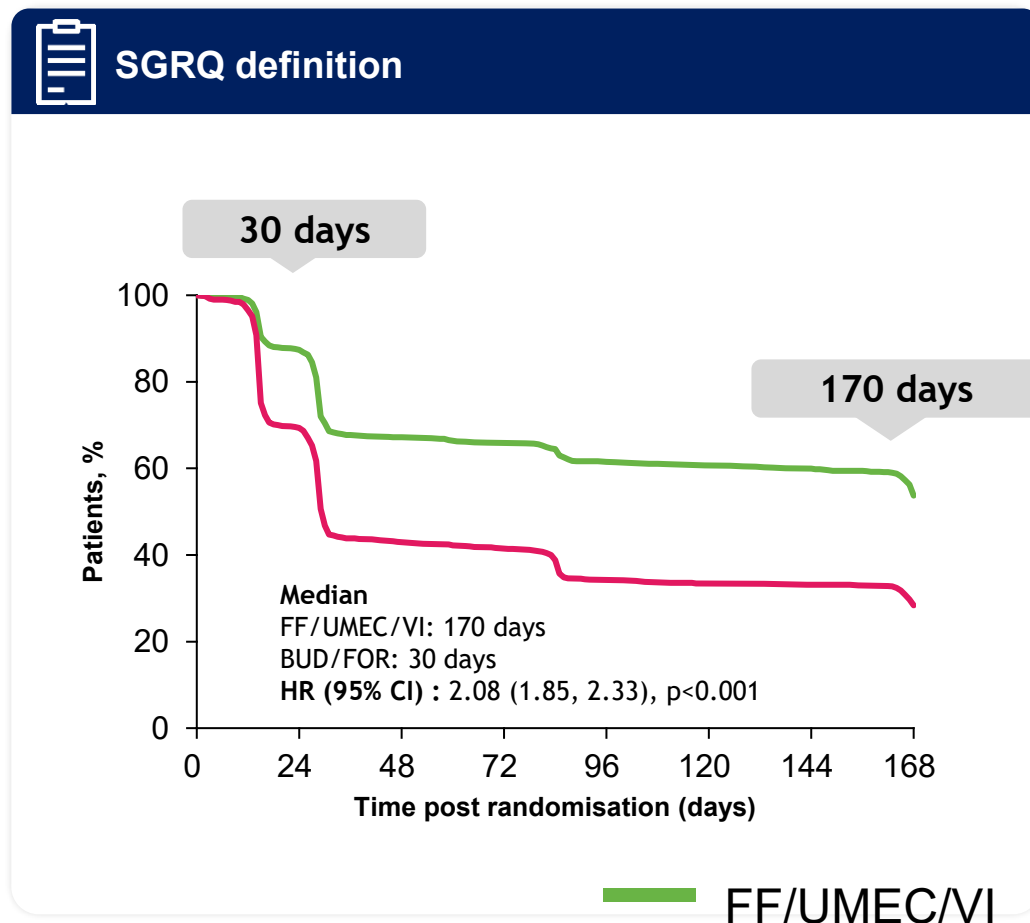
in the annual rate of moderate/severe exacerbations vs BUD/FOR (At Week 52; ARR: 0.16; 0.20/year vs 0.36/year, respectively; 95% CI: 15, 63; p=0.006)⁺¹

*The FULFIL trial was a Phase 3 RCT comparing 24 weeks of FF/UMEC/VI with twice-daily ICS/LABA therapy (BUD/FOR). Co-primary endpoints were CFB in trough FEV₁ and SGRQ total score at Week 24. The ITT population included 1810 patients with COPD;¹ ARR: 0.16; 0.20 vs 0.36, respectively; (TRELEGY Ellipta OD n=210, Symbicort Turbuhaler BD n=219), an extension population comprised of a subset of the ITT population (n=430/1810) who were enrolled into the 52-week extension phase of the study and remained on blinded treatment for up to 52 weeks.¹ Delivered dose for TRELEGY Ellipta FF/UMEC/VI: 92/55/22 µg. and SYMBICORT Turbuhaler BUD/FOR: 320/9 µg

BUD, budesonide; CI, confidence interval; FEV₁, forced expiratory volume in 1 second; FF, fluticasone furoate; FOR, formoterol; ITT, intent-to-treat; LS, least squares; OR, odds ratio; RR, rate ratio; SGRQ, St George's Respiratory Questionnaire; UMEC, umeclidinium; VI, vilanterol.
Lipson DA et al. Am J Respir Crit Care Med. 2017;196:438–46. 2.

Duración del mantenimiento de la estabilidad - Análisis post hoc de FULFIL

BUD/FOR frente a FF/UMEC/VI



Singh D et al. Presented at ATS 2024. Poster P630.

Sin embargo, el abordaje holístico en la EPOC es multidimensional y alineado al concepto de estabilidad de la enfermedad



Images depicted are stock images used solely for illustrative purposes. They do not represent real patients or individuals.

Disease stability as an endpoint has not yet been clinically validated.

1. Khan KS et al. *Cureus* 2023;15:e43694; 2. Spruit MA et al. *Am J Respir Crit Care* 2013;188:e13–64; 3. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. <https://goldcopd.org/2024-gold-report/> (accessed August 2024);

4. Liang Y et al. *Hum Vaccin Immunother* 2023;19:2286686.

¿Hay diferencias entre las dos estrategias de triple terapia en dispositivo único, hoy disponibles en nuestro medio?

- ✓ Mensajes clave del dispositivo ELLIPTA
- ✓ EFECTIVIDAD DIFERENCIAL ENTRE TRELEGY y FOR/GLIC/BUD

Efecto ininterrumpido de 24 horas, impulsado por moléculas diseñadas para durar*¹⁻⁶

UMECLIDINIUM (LAMA)

BRONCODILATACIÓN DE 24 HORAS
con inicio rápido y alta selectividad para los receptores*^{6,8,9}

FLUTICASONE FUROATE (ICS)

Acción ANTIINFLAMATORIA DE 24 HORAS
con baja exposición sistémica y alta afinidad de unión*^{†4,7*†4,7}

VILANTEROL (LABA)

BRONCODILATACIÓN DE 24 HORAS
con inicio rápido y alta selectividad para los receptores beta*^{†5,10,11}



Todo administrado por el inhalador Ellipta, fácil de usar y de enseñar^{12,13}

*Se desconoce la relevancia clínica de los datos *in vitro* o de los datos derivados de estudios en animales.

†El furoato de fluticasona y el vilanterol no están autorizados como monoterapias en la EPOC.

EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica; ICS, corticosteroide inhalado; LABA, agonista beta₂ de acción prolongada; LAMA, antagonista muscarínico de acción prolongada.

1. TRELEGY Ellipta SmPC, GSK. 2. Lipson DA et al. *Am J Respir Crit Care Med* 2017;196(4):438–446. 3. Lipson DA et al. *Adv Ther* 2020;37(12):4894–4909. 4. Daley-Yates PT. *Br J Clin Pharmacol* 2015;80(3):372–380. 5. Slack RJ et al. *J Pharmacol Exp Ther* 2013;344(1):218–230. 6. Naline E et al. *Pulm Pharmacol Ther* 2018;49:46–53. 7. Biggadike K et al. *J Med Chem* 2008;51(12):3349–3352. 8. Feldman G et al. *Int J Chron Obstruct Pulmon Dis* 2016;11:719–730. 9. Lainé DI. *J Med Chem* 2009;52(8):2493–2505. 10. Hanania N et al. *Chest* 2012;142(1):119–127. 11. Kempford R et al. *Pulm Pharmacol Ther* 2013;26(2):256–264. 12. Svedster H et al. *BMC Pulm Med* 2013;13:72. 13. van der Palen J et al. *NPJ Prim Care Respir Med* 2016;26:16079.

Altos niveles de satisfacción con Ellipta*^{1,2}

Los pacientes con EPOC lo describieron
como simple de operar y fácil de usar¹



>70 % de los pacientes tuvo preferencia por Ellipta^{1,2} vs <20 % para Turbuhaler, IDM, y otros inhaladores (cada uno de ellos $p<0.001$)



Huella de carbono hasta **25 veces menor** que la dosis equivalente con un IDM⁴

*Evaluación cualitativa de los atributos y la facilidad de uso del inhalador Ellipta a través de entrevistas cualitativas, profundas y semiestructuradas de pacientes con asma y EPOC (n=42).¹ Después de leer el folleto de información para el paciente, un número significativamente menor de pacientes con EPOC recibió críticas sobre errores al usar Ellipta que aquellos que utilizaban otros inhaladores. Más pacientes con EPOC tuvieron preferencia por Ellipta en lugar de los inhaladores de comparación. Al menos un error crítico: Ellipta vs Diskus (5 % vs 44 %), Ellipta vs IDM (13 % vs 60 %), Ellipta vs Turbuhaler (8 % vs 44 %), Ellipta vs HandiHaler (14 % vs 48 %) y Ellipta vs Breezhaler (13 % vs 46 %); todos ($p<0.001$).² †Comparación cruzada, inhalador de placebo, de visita única, en pacientes que nunca habían recibido Ellipta y los inhaladores de comparación (DISKUS n=171; IDM n=80; Turbuhaler n=100; HandiHaler n=118; Breezhaler n=98).² ‡Estudio de dos visitas, de baja intervención, de pacientes que cometieron ≥ 1 errores críticos en la práctica clínica habitual, comparando Ellipta con Turbuhaler (ICS/LABA), Diskus (ICS/LABA), HandiHaler (LAMA) o Breezhaler (LAMA/LABA).³ EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica; ICS, corticosteroide inhalado; LABA, agonista beta, de acción prolongada; LAMA, antagonista muscarínico de acción prolongada; IDM, inhalador de dosis medida. 1. Svedsater H et al. BMC Pulm Med 2013;13:72. 2. van der Palen J et al. NPJ Prim Care Respir Med 2016;26:16079. 3. Collier DJ et al. Int J Chron Obstruct Pulm Dis 2020;15:1301–1313. 4. Janson C et al. Thorax 2020;75:82–84.

Con Ellipta, los pacientes cometen menos errores críticos*^{1,2}



Menos errores críticos con Ellipta significa más confianza en que los pacientes reciben la dosis que necesitan^{1,2}

Como se ha demostrado en un estudio clínico....



5.5 veces menos vs Turbuhaler^{†1}
(8 % vs 44 %; n=100; $p<0.001$)



4.6 veces menos vs IDM^{†1}
(13 % vs 60 %, n=80; $p<0.001$)

...y en el mundo real

Hasta 7 veces menos errores críticos con Ellipta vs otros DPIs de uso frecuente, en un estudio del mundo real^{‡2}



*Los errores críticos se definieron como errores que probablemente resulten en que no se administre medicación al pulmón o que se administre una cantidad mínima de ella.^{1,2}

†Comparación cruzada, inhalador de placebo, de visita única, en pacientes que nunca habían recibido Ellipta y los inhaladores de comparación (DISKUS n=171; IDM n=80; Turbuhaler n=100; HandiHaler n=118; Breezhaler n=98).²

‡Estudio de dos visitas, de baja intervención, sobre errores críticos en la práctica clínica habitual, comparando Ellipta (FFV) con Turbuhaler (ICS/LABA), Diskus (ICS/LABA), HandiHaler (solo LAMA) o Breezhaler (LAMA/LABA). OR más bajo: Diskus PF/SAL (LAMA), n=26/100 vs Ellipta FFV (LAMA) n=11/100 (OR: 2.18; IC del 95 %: 0.94, 5.06; $p=0.069$). OR más alto: Turbuhaler BUDFOR + HandiHaler TIO y Diskus PF/SAL + HandiHaler TIO, n=50/99 vs Ellipta FFV (LAMA) n=6/50 (OR: 7.01; IC del 95 %: 2.51, 19.54; $p<0.001$).² BUD, budesonida; IC, intervalo de confianza; DPI, inhalador en polvo seco; FF, fumarato de fluticasona; FOR, fumarato de formoterol; PF, propionato de fluticasona; ICS, corticosteroide inhalado; LABA, agonista beta, de acción prolongada; LAMA, antagonista muscarínico de acción prolongada; IDM, inhalador de dosis medida; OR, índice de probabilidades; SAL, salmeterol; TIO, bromuro de tiotropio; VI, vilanterol.

1. van der Palen J et al. NPJ Prim Care Respir Med 2016;26:16079. 2. Collier DJ et al. Int J Chron Obstruct Pulm Dis 2020;15:1301–1313.

Estudio de efectividad comparativa del mundo real en pacientes con EPOC de FFS de Medicare de EE.UU. que escalaron de una doble terapia^{1,2}

Adv Ther
<https://doi.org/10.1007/s12325-025-03295-4>



ORIGINAL RESEARCH

Comparative Effectiveness of FF/UMEC/VI and BUD/GLY/FORM in Patients with COPD Stepping Up From Dual Therapy

Jadwiga A. Wedzicha¹ · Stephen G. Noorduyn² · Valentina Di Boscio · Olivier Le Rouzic³ · Anurita Majumdar · Rosirene Paczkowski⁴ · Stephen Weng⁵ · Guillaume Germain⁶ · François Laliberté⁷ · David Mannino⁸

Received: May 30, 2025 / Accepted: June 24, 2025
© The Author(s) 2025

ABSTRACT

Introduction: Recent data suggest differences in effectiveness of single-inhaler triple therapies (SITs) for patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD); however, data specifically from patients previously treated with dual bronchodilator therapy are lacking. This real-world comparative effectiveness study assessed patients with COPD treated with

fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol (FF/UMEC/VI) and budesonide/glycopyrrolate/formoterol fumarate (BUD/GLY/FORM) who stepped up from dual therapy. **Methods:** This retrospective study used health-care claims from the Komodo Research database to identify patients with COPD and Medicare Fee-for-Service insurance on dual therapy as their most recent treatment in the 90 days pre-index, stepping up to FF/UMEC/VI or BUD/GLY/FORM between January 1, 2016 and December 31, 2023. Primary outcome was annualized rate of moderate-severe exacerbations per patient-year (PPY) compared using rate ratios (RRs) and 95%

Supplementary Information The online version contains supplementary material available at <https://doi.org/10.1007/s12325-025-03295-4>.

J. A. Wedzicha
National Heart and Lung Institute, Imperial College
London, London, UK

S. G. Noorduyn (✉)
Global Real-World Evidence & Health Outcomes
Research, GSK, 100 Milverton Drive, Suite 800,
Mississauga, ON L5R 4H1, Canada
e-mail: stephen.g.noorduyn@gsk.com

S. G. Noorduyn
Department of Health Research Methods, Evidence
and Impact, McMaster University, Hamilton, ON,
Canada

V. Di Boscio
Global Medical Affairs, GSK, London, UK

O. Le Rouzic
Univ. Lille, CHU Lille, Institut Pasteur de Lille,
U1019 - UMR 9017 - CIL - Center for Infection
and Immunity of Lille, F-59000 Lille, France

A. Majumdar
Global Medical Affairs, GSK, Singapore, Singapore

R. Paczkowski
Global Real-World Evidence & Health Outcomes
Research, GSK, Collegeville, PA, USA

S. Weng
Respiratory Biostatistics, GSK, Stevenage, UK

G. Germain · F. Laliberté
Groupe d'analyse, SRL, Montréal, QC, Canada

D. Mannino
COPD Foundation, Lexington, KY, USA

D. Mannino
Pulmonary Epidemiology Research Laboratory,
University of Kentucky, Lexington, KY, USA

Published online: 07 July 2025

△ Adis

BUD, budesonida; EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica; FOR, formoterol; GLY, glicopirronio; ICS, corticosteroide inhalado; LABA, agonista beta 2 de acción prolongada; LAMA, antagonista muscarínico de acción prolongada.

1. Wedzicha JA;COPD;2025;1-6 | 2. Wedzicha JA; Adv Ther;2025;1-15 | 3. Información para prescribir Trelegy Ellipta aprobada en Colombia.

Efectividad comparativa entre TRELEGY y BUD/GLY/FOR

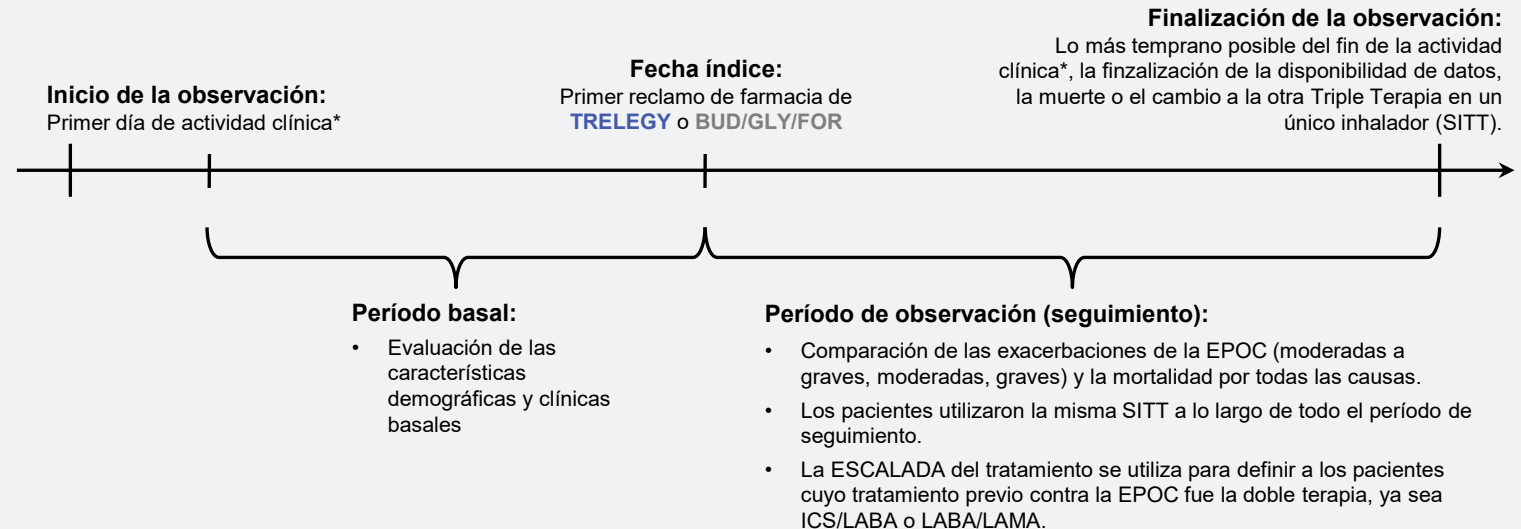
Estudio de cohortes, ponderado, del mundo real realizado en una población con EPOC de Medicare de EE.UU. que escaló su tratamiento de una doble terapia

Análisis retrospectivo de una base de datos de seguros médicos de EE. UU. del mundo real^{1,2}

Población del estudio: ~14 000 pacientes con EPOC de Pago por servicio de Medicare de EE.UU.^{1,2}

- Edad: >40 años
- Sin tratamiento previo de SITT
- 12 meses de actividad clínica*
- Los pacientes recibieron una doble terapia (ICS/LABA; LAMA/LABA) como su último tratamiento durante un mínimo de 90 días antes de la fecha del índice.

Diseño del estudio^{1,2}



Adaptado de Wedzicha, et al. 2025.

Objetivo y criterios de valoración del estudio

Objetivo del estudio

Comparar la efectividad de FF/UMEC/VI y BUD/GLY/FOR en las exacerbaciones en pacientes con EPOC que utilizaron la terapia dual como tratamiento más reciente antes de pasar a la SITT

DESENLACES DEL ESTUDIO

Primario: Tasa anualizada de exacerbaciones moderadas o graves de la EPOC en pacientes tratados con FF/UMEC/VI frente a BUD/GLY/FOR que utilizaron la terapia dual como tratamiento más reciente antes de escalar a la SITT

Secundarios: En pacientes tratados con FF/UMEC/VI frente a BUD/GLY/FOR que utilizaron la terapia dual como tratamiento más reciente antes de pasar a la SITT:

- Tiempo transcurrido hasta la primera exacerbación moderada-grave de la EPOC (analizada como un compuesto)
- Tiempo a la primera exacerbación moderada y tiempo a la primera exacerbación grave (analizadas por separado)

Exploratoria: Mortalidad por todas las causas entre pacientes tratados con FF/UMEC/VI y BUD/GLY/FOR

Los criterios de valoración de seguridad no fueron un objetivo en este estudio

Definiciones de exacerbaciones

- **Exacerbaciones moderadas:** ≥ 1 visita ambulatoria o al servicio de urgencias con un código de diagnóstico de exacerbación de la EPOC en la posición principal y ≥ 1 dispensación o administración de un SCS o antibiótico recomendado por las guías dentro de los 5 días siguientes o anteriores a la visita
- **Exacerbaciones graves:** Hospitalización con código diagnóstico de exacerbación de la EPOC en primera posición

Escalar a TRELEGY redujo significativamente la tasa anual de exacerbaciones moderadas/graves vs. BUD/GLY/FOR en pacientes con EPOC de Medicare de EE. UU.*1,2

No existen **ECCAs de comparación directa** que comparen **Triples Terapias en un único inhalador en la EPOC**, lo que deja una **brecha de conocimiento** a la hora de seleccionar estos tratamientos.

Los **estudios del mundo real** pueden ofrecer **información adicional** sobre la efectividad.^{1,2}

Población del estudio: ~14 000 pacientes de la base de datos de Pago por servicio de Medicare de EE. UU. que han recibido una doble terapia (ICS/LABA o LAMA/LABA) como su último tratamiento (≥ 90 días)*1,2

EP PRIMARIO:

LOS PACIENTES QUE ESCALARON A TRELEGY EXPERIMENTARON UN

 **18%**
p<0.001

MENOS DE EXACERBACIONES MODERADAS/GRAVES VS. BUD/GLY/FOR
TRELEGY 0.80 PPY vs. BUD/GLY/FOR 0.98 PPY;
RR: 0.82 (IC del 95%: 0.77, 0.88)

EP SECUNDARIO

SE OBSERVÓ UN RIESGO SIGNIFICATIVAMENTE MENOR DE EXPERIMENTAR UNA PRIMERA EXACERBACIÓN MODERADA/GRAVE DURANTE 12 MESES EN PACIENTES TRATADOS CON TRELEGY VS. BUD/GLY/FOR

Riesgo 14% menor de experimentar una exacerbación moderada/grave con TRELEGY vs. BUD/GLY/ FOR; FOR: 0.86 (IC del 95%: 0.81, 0.92), p<0.001. Durante 12 meses, la probabilidad/riesgo de experimentar al menos una exacerbación moderada/grave fue la siguiente: TRELEGY 43.6%, BUD/GLY/FOR 49.0%

- Se observó un riesgo significativamente menor de una primera exacerbación moderada durante 12 meses con TRELEGY vs. BUD/GLY/FOR†
- No se observaron diferencias significativas en el riesgo de una primera exacerbación grave‡ 1,2

EP EXPLORATORIO

SE OBSERVÓ UN RIESGO DE MORTALIDAD POR TODAS LAS CAUSAS **UN 18% MENOR** EN PACIENTES TRATADOS CON TRELEGY VS. BUD/GLY/FOR^{1,2}

Mortalidad por todas las causas: HR: 0.82 (IC del 95%: 0.68, 0.99); p=0.040 a los 12 meses Porcentaje de riesgo de mortalidad por todas las causas: TRELEGY 4.9% vs. BUD/GLY/FOR 6.0%

Los resultados reflejan la población estudiada y pueden no ser generalizables.^{1,2}

Las limitaciones de estudios del mundo real



En vida real puede ser diferente

**La Estabilidad en la EPOC
realmente es un un objetivo clínico
alcanzable aplicando estrategias
terapéuticas integradas**



@cri.neumología



@neumofajardo



cri.coordinación@gmail.com